Prefeitura Municipal de Parauapebas
Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2026

Parauapebas- PA, 2025

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Rua E, nº 481 – Cidade Nova, Parauapebas, PA CEP 68515-000

Fone: (94) 3346-1020 /3346-8532

Fundo Municipal de Saúde – CNPJ nº 12.581.232/0001-60

E-mail: semsa@parauapebas.pa.gov.br

MISSÃO

"Promover o acesso integral e humanizado à saúde, garantindo qualidade de vida e bem-estar ao cidadão".

VISÃO DE FUTURO

"Ser reconhecida pela excelência na promoção de saúde e qualidade de vida, de forma integral, resolutiva e inovadora".

VALORES

Ética, Humanização, Compromisso, Cooperação, Resolutividade, Eficiência e Transparência.

Prefeitura Municipal de Parauapebas
Secretaria Municipal de Saúde

AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

Prefeito Municipal de Parauapebas

FRANCISCO ALVES DE SOUZA

Vice-prefeito de Parauapebas

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO

Secretário Municipal de Saúde

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES

Chefe de Gabinete

MOISES VILLAS BOAS HAGE

Diretoria de Administração

ANA LÚCIA DE SOUSA NOGUEIRA

Diretoria da Atenção Primária em Saúde

MARCELO CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA

Diretoria de Vigilância em Saúde

LUZIA DE OLIVEIRA DA SILVA

Diretoria de Planejamento

MARIA FRANCISCA FRANÇA OLIVEIRA

Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação

KELIA DAS GRAÇAS DE PAIVA MACIAS NAKAI

Diretoria de Gestão do Desenvolvimento e Acompanhamento do Trabalhador

FRANCISCO FRANCILDO FONTINELE DE ARAUJO

Diretoria de Assistência Farmacêutica Municipal

AINA CHRISTINA OLIVEIRA NEGREIROS

Diretoria Financeiro

THAÍS CARDOSO DE OLIVEIRA

Diretoria da Atenção Especializada à Saúde

ANTONIO AERISON DE OLIVEIRA PASTANA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

EQUIPE DE TRABALHO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO GERAL

Irislene Alves de Almeida
Frank Sinatra da Silva Muniz
Allan Werbertt de Miranda

EQUIPE TÉCNICA DE COLABORAÇÃO

Diretoria de Planejamento

Fábio Sigesmundo de Britto
Mariusa Aparecida Gomes dos Santos
Lorene Raquel Ferreira Silva Lisboa
Aldezilma Oliveira Rodrigues
Neilson Correa Gonçalves
Rosana Maria dos Santos Rocha

Ouvidoria Municipal do SUS

Caticilene Sanches Leguli

Diretoria de Atenção Especializada

Dayseanne Costa Vieira Lemos
Thais Cardoso de Oliveira
Rafaela Pereira Gomes Pinto
Flavia Pinheiro Serpa dos Santos
Juliana Gomes de Araújo
Roberta Fabiula dos Anjos Cavalcante

Diretoria de Atenção Primária à Saúde

Ingrid Borchardt dos Santos Perego
Fernanda Teixeira da Silva

Diretoria de Assistencia Farmacêutica

Luciana Alves Nogueira Silva
Rogeria Alves Carvalho

Fundo Municipal de Saúde

Paulo Patrick Lima Potrich
Leidiana Braga da Silva

Diretoria de Controle, Regulação e Avaliação

Cleidiane Rosa Vilhena
Cilene Marques Ferreira

Diretoria de Administração

Erineudo Oliveira
Romulo Lopes da Silva

Diretoria de Gestão do Trabalho, Desenvolvimento e Acompanhamento do Trabalhador

Gabriela Correa Benguigui
Katia Fernandes do Amorim
Larissa de Sena Carvalho Pessoa
Deise Oliveira Souza Alves

Diretoria de Vigilância em Saúde

Raylane de Castro Moura
Joselene Aranha dos Santos
Livia Cristina Pereira Torres
Mickael Gross Santos Silva

Hospital Municipal de Parauapebas – Aselc

Clariane Acario Martins
Cristiane Viana Mendes Ribeiro

4. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - 2026

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE								
DIRETRIZ 1 - Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como ordenadora da Rede de Atenção à Saúde, garantindo acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade e equidade à população de Parauapebas.								
OBJETIVO 1.1 - Ampliar e qualificar a Atenção Primária à Saúde, assegurando cobertura, melhoria das infraestruturas, aprimoramento do processo de trabalho e valorização dos profissionais, resolutividade e coordenação do cuidado, com foco na universalização do acesso, à abrangência do cuidado integral, promoção da saúde e à prevenção de doenças e agravos.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			
1.1.1	**Ampliar a cobertura potencial da APS.**	**Cobertura potencial da Atenção Primária à Saúde no município.**	**2024**	**70,19%**	**percentual**	**74%**	**80%**	**percentual**
Ação Nº 1	Mapear áreas descobertas e planejar a implantação das novas equipes de Saúde da Família							
Ação N° 2	Dimensionar o pessoal necessário para compor as equipes e solicitar o provimento quando necessário							
Ação N° 3	Revisar o cadastro territorial das equipes de Saúde da Família (eSF), ajustando a área de abrangência das equipes para garantir que o número de pessoas por equipe não exceda o limite preconizado							
1.1.2	**Ampliar a cobertura populacional de Agentes Comunitários de Saúde na Atenção Primária à Saúde.**	**Cobertura populacional de ACS no município.**	**2024**	**76,64%**	**percentual**	**81%**	**90%**	**percentual**
Ação N° 1	Elaborar um plano de recursos humanos que preveja a reposição de vagas de ACS abertas por aposentadoria, exoneração ou licenças de longa duração, minimizando a perda de cobertura							
Ação N° 2	Dimensionar o pessoal necessário para compor as novas eSF e solicitar o provimento quando necessário							
1.1.3	**Ampliar o número de equipes Multiprofissionais vinculadas à eSF.**	**Número de equipes Multiprofissionais (eMulti) implantadas.**	**2024**	**6**	**número absoluto**	**4**	**10**	**número absoluto**

Ação N° 1	Solicitar junto ao Ministério da Saúde o credenciamento das novas equipes multiprofissionais de acordo com o cronograma de implantação							
Ação N° 2	Mapear as áreas e Equipes de Saúde da Família (eSF) que mais necessitam de apoio matricial, definindo o tipo de eMulti a ser implantada em cada território para otimizar o uso do recurso							
Ação N° 3	Realizar o dimensionamento de pessoal necessário para compor as equipes e solicitar o provimento quando necessário							
Ação N° 4	Adquirir insumos, materiais de consumo e equipamentos de uso das eMultis							
1.1.4	**Implantar equipe de Consultório na Rua – eCR.**	**Número de equipes de Consultório na Rua implantadas.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N° 1	Elaborar, em parceria com as redes de Atenção à Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social o Diagnóstico Situacional da população em situação de rua no município, identificando a localização, o perfil de saúde e as necessidades, para justificar tecnicamente a implantação da eCR							
Ação N° 2	Solicitar o novo credenciamento ao Ministério da Saúde da equipe de Consultório na Rua (eCR) na plataforma e-GestorAPS							
Ação N° 3	Realizar o dimensionamento de pessoal necessário para compor as equipes e solicitar o provimento quando necessário							
Ação N° 4	Criar um fluxo de trabalho formal com a Assistência Social (Centro POP), Segurança Pública e ONGs que atuam com a população de rua, garantindo a retaguarda social e a segurança da equipe em campo							
Ação N° 5	Aquirir um veículo adequado e seguro para o transporte da equipe e dos materiais de saúde, adaptado para o trabalho em diferentes pontos da cidade							
Ação N° 6	Prover kits de saúde portáteis (medicamentos básicos, curativos, testes rápidos, aferição de pressão/glicemia) para garantir que a equipe tenha resolutividade básica no local de atendimento							
1.1.5	**Promover a integralidade e a continuidade da assistência na Atenção Primária para as populações rurais, através da ampliação da frota destinada ao transporte sanitário eletivo municipal.**	**Número de veículos de transporte sanitário eletivo adquiridos.**	**2024**	**3**	**número absoluto**	**3**	**6**	**número absoluto**
Ação N° 1	Encaminhar processo para aquisição de veículos adaptados e exclusivos para o Transporte Sanitário Eletivo, em conformidade com as normas sanitárias e de acessibilidade vigentes.							
Ação N° 2	Garantir, anualmente na Programação Anual de Saúde (PAS), a previsão orçamentária para o custeio da frota, contemplando contratação/capacitação de motoristas, combustível, seguro, manutenção preventiva e corretiva dos veículos							
Ação N° 3	Estabelecer plano de manutenção preventiva e escala de motoristas capacitados em direção defensiva e primeiros socorros para atuar nessas rotas específicas.							

1.1.6	**Promover a equidade no acesso aos serviços de saúde, garantindo suporte logístico para que as equipes da APS realizem busca ativa e assistência domiciliar a idosos e comunidades rurais de difícil acesso.**	**Número de veículos próprios adquiridos para transporte das equipes da Atenção Primária.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**3**	**12**	**número absoluto**
Ação N° 1	Encaminhar processo para aquisição de frota específica e adaptada (veículos 4x4) de uso exclusivo das equipes da Atenção Primária à Saúde vinculadas às áreas rurais e de difícil acesso.							
Ação N° 2	Garantir, anualmente na Programação Anual de Saúde (PAS), a previsão orçamentária para o custeio da frota, contemplando contratação/capacitação de motoristas, combustível, seguro, manutenção preventiva e corretiva dos veículos							
Ação N° 3	Estabelecer plano de manutenção preventiva e escala de motoristas capacitados em direção defensiva e primeiros socorros para atuar nessas rotas específicas.							
1.1.7	**Elevar e estabilizar o Índice de Abastecimento Prioritário (IAP) nas unidades de saúde, visando atingir a meta pactuada de disponibilidade dos itens de custeio (materiais de consumo, insumos e etc.) e serviços de manutenção.**	**Índice de Abastecimento Prioritário (IAP) das Unidades Básicas de Saúde.**	**2024**	**S/I**	**índice**	**7**	**10**	**índice**
Ação N° 1	Definir a "Cesta de Itens Prioritários" por tipo de unidade, garantindo que itens críticos nunca fiquem abaixo do estoque de segurança.							
Ação N° 2	Estruturar e otimizar as rotas logísticas de distribuição entre a Central de Abastecimento Farmacêutico e o Almoxarifado e as Unidades Básicas de Saúde, garantindo que as cotas mensais de materiais cheguem nos prazos corretos.							
Ação N° 3	Encaminhar processo para aquisição de itens de custeio para a Atenção Primária à Saúde.							
Ação N° 4	Encaminhar processo para contratação de serviços de manutenção (refrigeração, impressão, equipamentos odontológicos e hospitalares) para as Unidades Básicas de Saúde.							
1.1.8	**Promover a atualização e a manutenção do Índice de Estruturação Patrimonial (IEP) nas Unidades Básicas de Saúde, garantindo as condições físicas e tecnológicas (equipamentos, mobiliários etc.) necessárias para o atendimento pleno à população.**	**Índice de Estruturação Patrimonial (IEP) das Unidades Básicas de Saúde.**	**2024**	**S/I**	**índice**	**7**	**10**	**índice**
Ação N° 1	Realizar inventário físico, tecnológico e patrimonial em todas as UBS, atualizando as informações de equipamentos instalados diretamente no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).							
Ação N° 2	Encaminhar processo para aquisição de materiais permanentes, equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, imobiliários e de tecnologia da informação (TI).							

Ação N° 3	Encaminhar processo para executar reformas, ampliações e adequações elétricas/hidráulicas nas unidades existentes para que comportem as novas tecnologias adquiridas, garantindo a acessibilidade.							
1.1.9	**Reformar Unidades Básicas de Saúde, qualificando a infraestrutura física e melhorando as condições de atendimento à população.**	**Número de Unidades Básicas de Saúde reformadas.**	**2024**	**3**	**número absoluto**	**8**	**22**	**número absoluto**
Ação N° 1	Elaborar projeto de reforma das Unidades Básicas de Saúde de acordo com o cronograma da APS							
Ação N° 2	Contratar empresa especializada para a reforma das UBS, de acordo com cronograma da APS							
Ação N° 3	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as UBS							
1.1.10	**Ampliar Unidades Básicas de Saúde, adequando a infraestrutura física à expansão da oferta de serviços da Atenção Primária à Saúde.**	**Número de Unidades Básicas de Saúde ampliadas.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**3**	**12**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Elaborar projeto de ampliação das Unidades Básicas de Saúde de acordo com o cronograma da APS							
Ação N.° 2	Contratar empresa especializada para a ampliação das UBS, de acordo com cronograma da APS							
Ação N.° 3	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as UBS							
1.1.11	**Construir Unidades Básicas de Saúde com Porte igual ou superior a IV, ampliando a capacidade instalada da Atenção Primária à Saúde no município.**	**Número de Unidades Básicas de Saúde com porte igual ou superior a IV construídas no período.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**1**	**6**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Acompanhar a execução da obra da UBS VS10							
Ação N.° 2	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as UBS VS10 que está em fase de construção							
Ação N.° 3	Contratar empresa especializada para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Nova Carajás							
Ação N.° 4	Identificar áreas institucionais existentes nos territórios para ampliação da cobertura da APS							
Ação N.º 5	Captar recursos via Governo Federal (Programas ou Emenda Parlamentar). Após a aprovação da proposta e a garantia do recurso (seja por programa ou emenda), cumprir todas as exigências documentais do Ministério da Saúde (ex: documentação do terreno, certidões negativas). Assinar o Termo de Convênio/Compromisso							
Ação N.° 6	Elaborar projeto básico e executivo das UBS seguindo as normas da ANVISA (RDC 50) e os padrões do Ministério da Saúde para tipologia de UBS (Porte I, II ou III)							
1.1.12	**Reduzir as internações por causas sensíveis à Atenção Primária.**	**Proporção de internações por causas sensíveis à Atenção Primária à Saúde.**	**2024**	**19,34%**	**percentual**	**18,80%**	**18,00%**	**percentual**

Ação N° 1	Reorganizar o processo de trabalho nas UBS para garantir acesso oportuno para demandas agudas e crônicas, minimizando a necessidade de busca por serviços de urgência e emergência hospitalar							
Ação N° 2	Manter o serviço de acolhimento à demanda espontânea diariamente em todas as Unidades Básicas de Saúde							
Ação N° 3	Identificar e realizar busca ativa de pacientes com condições crônicas de alto risco (diabetes e hipertensão descompensados), garantindo a captação e o acompanhamento regular							
Ação N° 4	Realizar reuniões de análise de dados com as equipes, identificando as principais causas de ICSAP por território (UBS/eSF) para direcionar as ações de intervenção mais urgentes							
1.1.13	**Ampliar a oferta, o acesso e o registro das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na Atenção Primária à Saúde, promovendo o cuidado integral e a promoção da saúde da população.**	**Número de atendimentos/ações de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) registrados na Atenção Primária à Saúde.**	**2024**	**2.284**	**número absoluto**	**2740**	**4.111**	**número absoluto**
Ação N° 1	Incluir a oferta de PICS (principalmente em grupo) no rol de serviços das equipes de Saúde da Família e das equipes multiprofissionais.							
Ação N° 2	Identificar e capacitar profissionais internos da rede (que já tenham experiência ou formação em PICS) para atuarem como facilitadores/instrutores no próprio município, promovendo a autonomia da gestão na Educação Permanente							
Ação N° 3	Assegurar o registro correto de todas as sessões de PICS realizadas no SISAB, utilizando os códigos de procedimento específicos (Ficha de Atividade Coletiva ou Ficha de Atendimento Individual)							
Ação N° 4	Adquirir materiais de consumo e equipamentos para a realização das PICS							
1.1.14	**Ampliar o acompanhamento e o registro da vigilância nutricional, com foco no enfrentamento da desnutrição e do baixo peso infantil, bem como do sobrepeso e da obesidade, em todos os ciclos de vida (crianças, adolescentes, adultos e idosos).**	**Número de indivíduos com estado nutricional avaliado e registrado no sistema de vigilância alimentar e nutricional.**	**2024**	**84.496**	**número absoluto**	**87.496**	**100.000**	**número absoluto**
Ação N° 1	Incluir a avaliação nutricional em todas consultas de rotina (pré-natal, puericultura, hipertensos, diabéticos) e atendimentos multidisciplinares							
Ação N° 2	Integrar a avaliação nutricional a campanhas de vacinação e ações de prevenção em massa nas UBS e nos territórios (escolas, centros comunitários, comunidades rurais)							
Ação N° 3	Prover novos equipamentos antropométricos e insumos de medição, acompanhando o cronograma de compras e manutenção preventiva para assegurar a continuidade do registro do estado nutricional nas UBS							

1.1.15	**Fortalecer a articulação e os fluxos assistenciais entre a Atenção Primária à Saúde do município e as Equipes de Saúde da Família Indígena (SESAI/DSEI), por meio de cooperação técnica, garantindo a integralidade do cuidado à população indígena no âmbito do SUS.**	**Número de fluxos assistenciais pactuados entre a rede municipal de saúde e o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.**	**2024**	**0**	**número absoluto.**	**2**	**5**	**número absoluto.**
Ação N° 1	Realizar uma ação assistencial com consultas e procedimentos de enfermagem, nutrição e dispensação de medicamentos a cada semestre							
Ação Nº 2	Realizar ações de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (Pré-natal, situação vacinal, avaliação nutricional)							
Ação N° 3	Realizar atendimentos odontológicos com atividades coletivas de escovação dental supervisionada							
1.1.16	**Ampliar o acesso aos serviços de saúde às populações do campo sem cobertura de equipes da APS.**	**Número de ações assistenciais básicas realizadas para a população do campo descobertas de equipes.**	**2024**	**0**	**número absoluto.**	**20**	**30**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Mapear as populações rurais do município de Parauapebas e da área do contestado, baseado no Termo de Cooperação 001/2025, identificando as demandas de saúde das populações rurais, respeitando a sua organização social, cultura, religião e o território							
Ação N.° 2	Estabelecer cronogramas de ações estratégicas que visem melhorar as condições de vida e saúde nas comunidades rurais que não possuem cobertura de equipes de Atenção Primária à Saúde							
Ação N.° 3	Identificar e solicitar os recursos (pessoal e insumos) necessários para levar assistência em saúde a essas comunidades							
Ação N.° 4	Condensar os dados epidemiológicos de forma que forneçam informações estruturais para subsidiar as tomadas de decisão de forma qualificada							
1.1.17	**Reduzir a taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).**	**Taxa de mortalidade prematura (30 - 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).**	**2024**	**253,61**	**taxa**	**223,31**	**121,22**	**taxa**
Ação N.º 1	Ampliar o rastreamento e o diagnóstico precoce de hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias e cânceres mais prevalentes (mama, colo de útero, próstata e colorretal)							
Ação N.° 2	Capacitar equipes da APS em abordagem integral das DCNT, estratificação de risco e educação em saúde							
Ação N.° 3	Desenvolver ações intersetoriais voltadas para alimentação saudável, atividade física, combate ao tabagismo, consumo nocivo de álcool e redução do estresse							
Ação N.° 4	Realizar Campanhas educativas anuais (“Dia Mundial do Coração”, “Novembro Azul”, “Outubro Rosa”)							
Ação N.º 5	Ampliar acesso a consultas especializadas e exames de média complexidade (cardiologia, endocrinologia, oncologia, pneumologia)							

1.1.18	**Aumentar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família – PBF nas vigências.**	**Proporção de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família realizados nas vigências.**	**2024**	**76,02%**	**percentual**	**78%**	**80%**	**percentual**
Ação N° 1	Capacitar as equipes de saúde sobre os procedimentos corretos de registro, a importância do acompanhamento e o preenchimento das condicionalidades de saúde							
Ação N° 2	Pactuar com a Secretaria Municipal de Educação a solicitação do número do NIS no ato da matrícula dos alunos da rede pública de ensino, para o acompanhamento dos alunos beneficiários durante as ações do PSE							
Ação N° 3	Implementar rotinas trimestrais de busca ativa focada nas famílias não acompanhadas							
Ação N° 4	Realizar campanhas de comunicação contínuas nas UBS e canais digitais sobre a importância do acompanhamento de saúde para a permanência no PBF							
Ação Nº 5	Realizar mutirões em datas estratégicas para facilitar o acesso de famílias com dificuldade de comparecimento, principalmente aquelas que residem em áreas descobertas por equipes de Saúde da Família							
1.1.19	**Ampliar a identificação precoce do risco para TEA, por meio da aplicação do M-CHAT-R/F em 75% das crianças de 16 a 30 meses atendidas nas UBS até 2029, favorecendo o encaminhamento e o acompanhamento oportuno.**	**Percentual de crianças de 16 a 30 meses avaliadas com o instrumento M-CHAT-R/F.**	**2024**	**0**	**percentual**	**13%**	**50%**	**percentual**
Ação N° 1	Promover treinamento prático intensivo para os profissionais de saúde que realizam puericultura, abordando a aplicação, pontuação e interpretação do M-CHAT-R, bem como a comunicação sensível do resultado com as famílias							
Ação N° 2	Incluir o M-CHAT-R na rotina de atendimento das consultas de puericultura na idade de 16 e 30 meses							
1.1.20	**Implantar pontos de telessaúde na APS.**	**Número de pontos de telessaúde implantados.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**3**	**10**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Encaminhar processo para compra de equipamentos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) adequados (computadores com câmera de alta resolução, headsets, monitores duplos) para estruturar as salas de telessaúde nas UBS.							
Ação N.° 2	Desenvolver atividades de formação para as equipes de Saúde da Família (médicos, enfermeiros, agentes comunitários) sobre letramento digital, uso das plataformas (como o e-SUS APS) e protocolos operacionais para a realização de teleinterconsultas e telediagnósticos.							
Ação N.° 3	Estabelecer o fluxo técnico integrando os pontos de telessaúde da APS ao Complexo Regulador Municipal (SISREG/e-SUS Regulação). A teleconsultoria entre o médico da família (na UBS) e o especialista deve servir como ferramenta para qualificar o encaminhamento ou resolver o caso localmente, evitando deslocamentos desnecessários e reduzindo a fila de espera física.							
1.1.21	**Reduzir mortalidade infantil por meio da qualificação da atenção pré-natal, puericultura e identificação precoce de risco.**	**Taxa de Mortalidade Infantil.**	**2024**	**15,38**	**taxa**	**14,88**	**13,38**	**taxa**

Ação N.º 1	Intensificar a importância do acompanhamento adequado da gestante e identificação precoce de riscos que possam comprometer o nascimento e a sobrevivência do bebê							
Ação N.° 2	Promover parto seguro e humanizado, reduzindo complicações neonatais e maternas							
Ação N.° 3	Fortalecer a prevenção de infecções e agravos preveníveis por vacina e a melhora do estado nutricional infantil							
Ação N.° 4	Fortalecer a atenção ao recém-nascido e à puericultura							
Ação N.º 5	Reforçar a vigilância e investigação dos óbitos infantis e fetais							
1.1.22	**Ampliar e qualificar o cuidado integral no desenvolvimento infantil na Atenção Primária à Saúde, assegurando o acesso oportuno, o acompanhamento longitudinal e a adoção de boas práticas de promoção da saúde e do desenvolvimento de crianças de zero a dois anos de idade.**	**Proporção de crianças de zero a dois anos acompanhadas de forma integral pela Atenção Primária à Saúde.**	**2024**	**SI**	**percentual**	**26%**	**51%**	**percentual**
Ação N.º 1	Instituir o uso obrigatório e sistemático da Caderneta da Criança em todas as consultas, com foco no preenchimento dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor.							
Ação N.° 2	Organizar a agenda das Equipes de Saúde da Família (ESF) para garantir as consultas de rotina (crescimento e desenvolvimento) da primeira infância, promovendo a busca ativa de crianças faltosas nas consultas e no calendário vacinal.							
Ação N.° 3	Encaminhar processo para aquisição e manutenção dos equipamentos antropométricos adequados nas UBS (balanças pediátricas digitais, réguas antropométricas) e assegurar a disponibilidade de insumos básicos.							
Ação N.° 4	Estabelecer um fluxo regulatório rápido entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada para os casos em que a ESF identifique atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor da criança (ex: encaminhamento para estimulação precoce no CER IV ou no ambulatório de alto risco).							
1.1.23	**Reduzir a Mortalidade Materna no município, por meio da qualificação do pré-natal, identificação precoce de risco e resposta oportuna às urgências obstétricas.**	**Razão da mortalidade materna no município.**	**2024**	**89,16**	**razão**	**84,3**	**70**	**razão**
Ação N.º 1	Ampliar o acesso ao financiamento e a qualidade do pré-natal, com enfoque na detecção precoce de agravos							
Ação N.° 2	Fortalecer a vigilância epidemiológica e a investigação dos óbitos maternos							
Ação N.° 3	Assegurar a ligação eficiente entre a atenção básica e o local de parto							
Ação N.° 4	Fortalecer o suporte de equipes multiprofissionais à mulher, o que inclui apoio psicológico e orientação sobre amamentação e cuidados com o bebê							
Ação N.º 5	Fortalecer o acesso a métodos contraceptivos e informações sobre saúde sexual e reprodutiva, permitindo que as mulheres planejem suas gestações							

Ação N.° 6	Fortalecer a Rede Alyne							
1.1.24	**Ampliar e qualificar o cuidado integral às gestantes e puérperas na Atenção Primária à Saúde, assegurando captação precoce, acompanhamento coordenado e contínuo, e adoção de boas práticas assistenciais ao longo da gestação e do puerpério.**	**Proporção de gestantes e puérperas acompanhadas de forma integral pela Atenção Primária à Saúde.**	**2024**	**SI**	**percentual**	**45%**	**76%**	**percentual**
Ação N° 1	Prover o acesso à primeira consulta de pré-natal até a 12ª semana de gestação							
Ação N° 2	Identificar as gestantes que faltaram à consulta agendada e realizar a busca ativa para reagendamento do acompanhamento							
Ação N° 3	Assegurar o fornecimento ininterrupto de insumos básicos (sulfato ferroso, ácido fólico)							
Ação N° 4	Pactuar fluxo ágil dos exames laboratoriais de rotina (Tipagem Sanguínea, Glicemia, VDRL, Testes Rápidos)							
1.1.25	**Reduzir a proporção de gestações em adolescentes de 10 a 19 anos no município, por meio do fortalecimento das ações de saúde sexual e reprodutiva na Atenção Primária à Saúde.**	**Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos em relação ao total de nascidos vivos no município.**	**2024**	**13,31%**	**percentual**	**13,09%**	**12,70%**	**percentual**
Ação N° 1	Realizar grupos de saúde de adolescentes nas UBSs com temas diversos, incluindo prevenção de IST/AIDS, planejamento familiar, autocuidado e tomada de decisão responsável							
Ação N° 2	Fortalecer parcerias institucionais no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes							
Ação N° 3	Monitorar a implementação do protocolo de escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências nos serviços de saúde							
1.1.26	**Ampliar o percentual de exames de rastreamento de câncer de colo de útero de mulheres cadastradas na APS na faixa etária de 25 a 64 anos e com avaliação nos últimos 36 meses.**	**Percentual de mulheres de 25 a 64 anos cadastradas na APS com exame de rastreamento do câncer de colo do útero solicitado, realizado ou avaliado nos últimos 36 meses.**	**2024**	**SI**	**percentual**	**45%**	**76%**	**percentual**
Ação N° 1	Utilizar o sistema de informação da APS para gerar uma lista nominal de mulheres de 25 a 64 anos que não realizaram o exame nos últimos 36 meses e realizar a busca ativa							
Ação N° 2	Realizar ações de saúde itinerantes ou educativas em locais com grande concentração de mulheres, oferecendo agendamento facilitado e material educativo							

Ação N° 3	Organizar, pelo menos uma vez por mês, horários de atendimento estendidos nas UBS para a coleta de Papanicolau e outros exames ginecológicos, visando atender a população que trabalha em horário comercial							
Ação N° 4	Analisar o percentual de rastreamento separadamente por subgrupos (25-34 anos; 35-49 anos; 50-64 anos) para identificar onde a cobertura está mais crítica e direcionar campanhas específicas							
1.1.27	**Ampliar o rastreamento de câncer de mama em mulheres e homens transgênero na faixa etária de 50 a 74 anos.**	**Proporção de mulheres e homens transgênero de 50 a 74 anos com registro de pelo ao menos 1 exames de mamografia de rastreamento solicitado, realizado ou avaliado nos últimos 24 meses.**	**2024**	**SI**	**percentual**	**26%**	**51%**	**percentual**
Ação N.º 1	Implementar rotinas de busca ativa por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e equipes da Atenção Primária para identificar mulheres e homens transgêneros na faixa de 50 a 69 anos, garantindo o agendamento do exame e a "navegação" (acompanhamento) do usuário pela Rede de Atenção à Saúde para evitar o absenteísmo.							
Ação N.° 2	Utilizar os dados do PEC para identificar todas as mulheres na faixa de 50 a 74 anos por território, sinalizando aquelas com exames vencidos há mais de dois anos.							
Ação N.° 3	Pactuar e organizar o fluxo na Central de Regulação Municipal para que casos suspeitos (BI-RADS 4 ou 5) identificados no rastreamento tenham acesso prioritário e garantido à consulta com mastologista e à biópsia (punção por agulha grossa/fina) em tempo oportuno (Lei dos 30 dias).							
1.1.28	**Qualificar o cuidado integral às pessoas com diabetes na Atenção Primária à Saúde, fortalecendo a captação, o acompanhamento clínico regular e a adoção de boas práticas assistenciais, com foco na prevenção de complicações e na melhoria da qualidade de vida.**	**Proporção de pessoas com diabetes acompanhadas de forma integral na Atenção Primária à Saúde.**	**2024**	**SI**	**Percentual**	**45%**	**76%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Organizar as agendas das Equipes de Saúde da Família (eSF) para garantir o cuidado contínuo e rastreio de pacientes diabéticos faltosos, assegurando o registro adequado dos exames de hemoglobina glicada e avaliação de risco cardiovascular.							
Ação N.° 2	Classificar os pacientes diabéticos por grau de risco (baixo, médio, alto) no PEC, definindo a periodicidade das consultas e exames para cada perfil.							
Ação N.° 3	Encaminhar, junto à Assistência Farmacêutica, processo para aquisição e dispensação contínua de medicamentos essenciais e insumos para automonitoramento da glicemia capilar (tiras reagentes, glicosímetros, canetas aplicadoras e insulinas).							
Ação N.° 4	Instituir protocolos na APS para a avaliação periódica dos pés diabéticos (prevenção de amputações) e do fundo de olho (prevenção de cegueira), utilizando o apoio matricial das Equipes Multiprofissionais (eMulti).							
Ação N.° 5	Desenvolver atividades coletivas focadas no estímulo à alimentação adequada e à prática de atividades físicas para controle metabólico, reduzindo os fatores de risco (sobrepeso e obesidade).							

1.1.29	**Ampliar e qualificar o acompanhamento das pessoas com hipertensão na Atenção Primária à Saúde, assegurando acesso oportuno, monitoramento clínico contínuo e ações integradas de prevenção de agravos e complicações cardiovasculares.**	**Proporção de pessoas com hipertensão arterial acompanhadas de forma integral na Atenção Primária percentual à Saúde.**	**2024**	**SI**	**percentual**	**45%**	**76%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Organizar as agendas das Equipes de Saúde da Família (eSF) para garantir o cuidado contínuo, a aferição da pressão arterial e a busca ativa de pacientes hipertensos faltosos, assegurando o registro adequado no Prontuário Eletrônico.							
Ação N.° 2	Encaminhar processo para contratualização de prestação de serviço de manutenção e aquisição regular de esfigmomanômetros (aparelhos de pressão) e estetoscópios para todas as UBS.							
Ação N.° 3	Encaminhar, junto à Assistência Farmacêutica, processo para aquisição e dispensação contínua de medicamentos anti-hipertensivos (como Losartana, Captopril, Enalapril, etc.) nas farmácias das UBS.							
Ação N.° 4	Viabilizar, junto ao Laboratório Municipal, a realização anual de exames básicos de monitoramento (Creatinina, ECG, Perfil Lipídico e Potássio).							
Ação N.° 5	Desenvolver atividades coletivas e educação em saúde com o apoio das Equipes Multiprofissionais (eMulti), focando na promoção da atividade física, controle do tabagismo e redução do consumo de sal/sódio.							
1.1.30	**Fortalecer o cuidado integral à pessoa idosa na Atenção Primária à Saúde, com ênfase no acompanhamento longitudinal, na promoção da autonomia, na prevenção de agravos e na atenção às pessoas idosas em situação de maior vulnerabilidade.**	**Proporção de pessoas idosas acompanhadas de forma integral pela Atenção Primária à Saúde.**	**2024**	**SI**	**Percentual**	**45%**	**76%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Instituir a rotina obrigatória de aplicação da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa e do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20) por parte das Equipes de Saúde da Família (eSF), classificando os idosos em independentes, com risco de fragilização ou frágeis.							
Ação N.° 2	Integrar na consulta de rotina da APS a aplicação de testes de mobilidade (como o Timed Up and Go) e a avaliação do ambiente domiciliar por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).							
Ação N.° 3	Realizar oficinas coletivas com idosos e cuidadores sobre adaptações domiciliares seguras (retirada de tapetes, melhoria da iluminação) e a importância da atividade física para fortalecimento muscular.							
Ação N.° 4	Viabilizar o acesso prioritário a exames laboratoriais e de imagem para idosos com critérios de fragilidade estabelecidos, integrando os dados com a regulação municipal.							
1.1.31	**Reduzir de internação de pessoas idosas por fratura de fêmur.**	**Reduzir a taxa de internação de pessoas idosas por fratura de fêmur.**	**2024**	**3,01**	**taxa**	**≤ 2,94**	**≤ 2,77**	**taxa**

Ação N.º 1	Promover a prevenção de quedas e promover envelhecimento saudável, junto à APS							
Ação N.° 2	Assegurar continuidade e integralidade do cuidado							
Ação N.° 3	Implementar a Linha de Cuidado da Pessoa Idosa com foco em prevenção de quedas							
1.1.32	**Ampliar a cobertura de Saúde Bucal na APS.**	**Cobertura populacional pela eSB vinculadas à eSF.**	**2024**	**26,13%**	**percentual**	**45%**	**70%**	**percentual**
Ação N° 1	Mapear áreas descobertas e planejar a implantação das novas equipes de Saúde Bucal							
Ação N° 2	Dimensionar o pessoal necessário para compor as equipes e solicitar o provimento quando necessário							
Ação N° 3	Vincular novas eSB às Equipes de Saúde da Família (eSF) em operação, assegurando o trabalho em conjunto no território e a adscrição de usuários							
Ação N° 4	Elaborar um Plano de Investimento em Odontologia para a aquisição de novos equipamentos odontológicos (cadeiras, compressores, fotopolimerizadores) para as novas equipes							
Ação N° 5	Prover a manutenção preventiva e corretiva dos consultórios em funcionamento;							
Ação N° 6	Adquirir insumos, materiais de consumo e instrumentais odontológicos							
Ação N° 7	Manter os atendimentos odontológicos realizados nas Unidades Odontológicas Móveis – UOMs							
Ação N° 8	Realizar convênio com Laboratório Regional de Próteses Dentárias – LRPD							
1.1.33	**Construir o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO (Tipo III).**	**Centro de Especialidade Odontológica – CEO Tipo III construído.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
1.1.34	**Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III, ampliando o acesso da população aos serviços odontológicos especializados no município.**	**Centro de Especialidades Odontológicas - CEO (tipo III) habilitado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
1.1.35	**Aderir o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) à Rede de Cuidado a Pessoas com Deficiência (RCPD) ampliando e qualificando o cuidado às especificidades das pessoas com deficiência que necessita de atendimento odontológico.**	**CEO-RCPD habilitado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

1.1.36	**Ampliar a proporção de atendimentos odontológicos a pessoa com deficiência.**	**Proporção de atendimentos odontológicos a pessoa com deficiência.**	**2024**	**26,64%**	**percentual**	**35%**	**50%**	**percentual**
Ação N.º 1	Mapear pessoas com deficiência adscritas nas microáreas das equipes de Saúde da Família							
Ação N.° 2	Promover educação permanente e continuada das equipes de Saúde da família e equipes de Saúde Bucal de referência quanto ao cadastro das Pessoas com Deficiência no Sistema de Informação Vigente, com ofertas de oficinas de sensibilização sobre acessibilidade e inclusão							
Ação N.° 3	Criar fluxos preferenciais de atendimento para PcDs com mobilidade reduzida ou dependentes de transporte.							
1.1.37	**Promover a reabilitação protética dos usuários da rede de saúde através do convênio com Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).**	**Número de próteses dentárias instaladas.**	**2024**	**800**	**número absoluto**	**1265**	**1463**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Formalizar o convênio/contrato com o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), garantindo a adequação dos cadastros no CNES (Subtipo de Estabelecimento 39.03) e a vinculação do profissional Protético Dentário (CBO 3224-10).							
Ação N.° 2	Instituir e padronizar o protocolo clínico de referência e contrarreferência para reabilitação protética nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).							
Ação N.° 3	Parametrizar os sistemas de faturamento municipal para o registro rigoroso da produção do LRPD.							
Ação N.° 4	Apresentar a prestação de contas da produção protética ao Conselho Municipal de Saúde.							
1.1.38	**Ampliar a cobertura de consulta programada de odontologia em gestante no município.**	**Proporção de gestante com pelo menos 01 consulta odontológica programada realizada.**	**2024**	**67%**	**percentual**	**70%**	**85%**	**percentual**
Ação N.º 1	Instituir e oficializar um protocolo de fluxo interno nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) denominado "Pré-Natal Odontológico"							
Ação N.° 2	Integrar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na captação de gestantes faltosas.							
Ação N.° 3	Realizar atividades educativas durante as reuniões de grupos de gestantes, abordando mitos sobre o tratamento odontológico na gravidez e a importância da higiene bucal para a saúde do binômio mãe-filho.							
1.1.39	**Qualificar anualmente os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) nas áreas estratégicas e linhas de cuidado (saúde da mulher, da criança, do idoso, saúde mental, condições crônicas e etc).**	**Percentual de profissionais da APS capacitados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**60%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Garantir espaço protegido na carga horária semanal das Equipes de Saúde da Família (eSF), Equipes de Atenção Primária (eAP), Equipes de Saúde Bucal (eSB) e equipes Multiprofissionais (eMulti) para atividades de Educação Permanente em Saúde (EPS) dentro da própria UBS.							
Ação N.° 2	Executar o programa "Qualifica SUS Parauapebas" focado exclusivamente no perfil de morbimortalidade local (Diagnóstico Situacional).							
Ação N.° 3	Fomentar o uso de plataformas de educação à distância e teleconsultorias formativas.							

Ação N.° 4	Instituir um sistema de controle de Recursos Humanos (plataforma digital ou planilhas do Setor de Ações Educacionais) para rastrear nominalmente a carga horária de treinamento de cada servidor							
1.1.40	**Implantar o Programa Academia da Saúde com a construção e habilitação de Polos do Programa.**	**Número de Polo do Programa Academia da Saúde construído e habilitado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
1.1.41	**Ampliar a cobertura de médicos vinculados ao Programa Mais Médicos para Brasil garantindo provimento médico nas equipes de Saúde da Família prioritárias do município.**	**Número de equipes de Saúde da Família composta por médicos do Programa Mais Médicos.**	**2024**	**29**	**número absoluto**	**Não programado**	**21**	**número absoluto**

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DIRETRIZ 2 - Organizar, ampliar e qualificar a Atenção Especializada e Hospitalar de Média e Alta Complexidade no município, garantindo acesso oportuno, redução de filas, integralidade do cuidado e fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, em consonância com as políticas e programas estadual e do Ministério da Saúde.

OBJETIVO 2.1 - Qualificar e ampliar a capacidade instalada e resolutiva da atenção especializada em saúde e hospitalar de média e alta complexidade alinhada com Rede de Atenção às Urgências, expandindo e implantado novas estruturas, habilitando novos serviços, garantindo acesso oportuno e atendimento integral à população de Parauapebas.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
2.1.1	**Ampliar o número de Base Descentralizada do SAMU 192 com sua construção e habilitação para cobrir vazios assistenciais de saúde no município.**	**Número de Base Descentralizadas do SAMU 192 construídas e habilitadas.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
2.1.2	**Ampliar o número de Unidade de Suporte Básico (USB) com habilitação e aquisição de veículos para transporte de pacientes no âmbito do SAMU 192.**	**Número de veículo USB adquirido e habilitado.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**4**	**número absoluto**
2.1.3	**Ampliar o número de Unidade de Suporte Avançado (USA) com habilitação e aquisição de veículos para transporte de paciente no âmbito do SAMU 192**	**Número de veículo USA adquirido e habilitado.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

2.1.4	**Promover a renovação da frota do SAMU 192, assegurando conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde e melhoria do tempo-resposta.**	**Número de ambulâncias renovadas**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
2.1.5	**Implantar serviço de motolância para o SAMU 192 com aquisição do veículo e habilitação do serviço.**	**Serviço de motolância SAMU 192 habitado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
2.1.6	**Reformar a base descentralizada do SAMU 192 qualificando a infraestrutura física e melhorando as condições de trabalho da equipe.**	**Número de Base descentralizada SAMU 192 reformada**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
2.1.7	**Realizar e manter a qualificação do Serviço Móvel de Urgência SAMU 192 junto ao MS.**	**Número de qualificação do SAMU 192 junto ao MS.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**2**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar capacitação permanente dos servidores vinculados ao componente SAMU 192, com os cursos obrigatórios.							
Ação N.º 2	Comprovar a vigência do seguro contra sinistro para as Unidades Móveis							
Ação N.º 3	Contratar manutenção das Unidades Móveis SAMU 192.							
Ação N.º 4	Adquirir os uniformes das equipes assistenciais, obedecendo ao padrão visual estabelecido pelo Ministério da Saúde, e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).							
Ação N.º 5	Reformar a Base Descentralizada mantendo a padronização visual, conforme normatização específica constante do manual de identidade visual do Ministério da Saúde.							
Ação N.º 6	Adquirir e realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos.							
2.1.8	**Reduzir o tempo médio de resposta de atendimento do SAMU de 20 minutos em 2024 para 15 minutos até 2029.**	**Tempo médio de resposta de atendimento das equipes do SAMU**	**2024**	**20**	**número absoluto**	**≤19**	**≤15**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Aperfeiçoar a articulação com a Central de Regulação das Urgências - CRU para manter o tempo médio total de regulação em até 5 minutos							
Ação N.º 2	Integrar ações com o Núcleo Interno de Regulação -NIR do Hospital Geral de Parauapebas - HGP para agilizar a confirmação e liberação de leitos							
Ação N.º 3	Monitorar intervalo entre o acionamento e saída da base das equipes operacionais							
Ação N.º 4	Manter o funcionamento do sistema de comunicação entre CRU e equipe (celular ativo)							
Ação N.º 5	Qualificar 02 serviços existentes (Unidade de Suporte Básico e Unidade de Suporte Avançado)							
Ação N.º 6	Participar das ações educativas nos serviços de saúde e na comunidade							

Ação N.º 7	Implantar sistemas de informação para apoiar a gestão e o monitoramento das ações							
Ação N.º 8	Realizar a manutenção preventiva e corretiva na frota do SAMU							
Ação N.º 9	Construir duas bases descentralizadas							
Ação N.º 10	Adquirir 02 motolâncias							
Ação N.º 11	Ampliar frota de Unidade de Suporte Básico - USB							
Ação N.º 12	Implantar e habilitar três novos serviços (uma ambulância USB e duas motolâncias)							
Ação N.º 13	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento do serviço							
2.1.9	**Solicitar ao MS alteração de modalidade da UPA Sebastião Barbosa, para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) opção VI de funcionamento.**	**UPA habilitada na modalidade opção VI de funcionamento.**	**2024**	**1- Tipo II**	**número absoluto**	**Não programado**	**1 - Tipo VIII**	**número absoluto**
2.1.10	**Solicitar e manter a qualificação dos serviços da UPA Sebastião Barbosa junto ao MS.**	**UPA qualificada junto ao MS.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.11	**Ampliar o serviço de Pronto Atendimento com a construção e habilitação de uma unidade opção III de funcionamento.**	**UPA opção III construída e habilitada**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.12	**Reformar a UPA Sebastião Barbosa qualificando a infraestrutura física e melhorando as condições de trabalho e de atendimento à população.**	**Número de reforma na UPA Sebastião Barbosa.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
2.1.13	**Realizar mudança da tipologia da porta de entrada de urgência do Hospital Geral de Parauapebas para Hospital Especializado Tipo II.**	**Hospital Geral de Parauapebas porta de entrada de urgência especializada tipo II habilitado junto ao MS.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.14	**Qualificar a porta de entrada de urgência do Hospital Geral de Parauapebas.**	**HGP qualificado**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.15	**Ampliar número de leitos de terapia intensiva adulta no HGP.**	**Número de leitos de UTI implantados e habilitados**	**2024**	**10**	**número absoluto**	**Não programado**	**10**	**número absoluto**
2.1.16	**Qualificar leitos de terapia intensiva adulta no HGP.**	**Qualificar leitos**	**2024**	**10**	**número absoluto**	**Não programado**	**10**	**número absoluto**

2.1.17	**Implanta leitos de terapia intensiva infantil.**	**Número de leitos de UTI infantil implantados e habilitados**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**10**	**número absoluto**
2.1.18	**Implantar o serviço de unidade coronariana, solicitando para MS investimento de implantação de leitos de unidade coronariana (UCO).**	**Número de leitos UCO implantados.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.19	**Habilitar o HGP junto ao MS como Centro de atendimento de urgência tipo II referência para atendimento aos pacientes com AVC.**	**HGP habilitado como centro de referência tipo II para AVC.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.20	**Implantar e qualificar a Linha de cuidado ao trauma no HGP**	**Linha de cuidado implantada**	**2024**	**S/I**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.1.21	**Manter os leitos de enfermaria de retaguarda clínica**	**Manter leitos de retaguarda clínica implantados.**	**2024**	**100%**	**percentual**	**100%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Submeter 100% dos leitos de retaguarda clínica à regulação integral pelas Centrais de Regulação de Leitos e gerenciar o fluxo interno através do Núcleo Interno de Regulação (NIR)							
Ação N.º 2	Implantar rondas e visitas multidisciplinares horizontais diárias nas enfermarias clínicas de retaguarda, utilizando prontuário único							
Ação N.º 3	Alimentar rigorosa e mensalmente o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) com a produção e as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) destes leitos							
2.1.22	**Qualificar os leitos de enfermaria de retaguarda clínica**	**Qualificar leitos**	**2021**	**100%**	**percentual**	**Não programado**	**100%**	**percentual**
2.1.23	**Implantar unidade de cuidados prolongados.**	**Número de leitos cuidados prolongados implantados.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**15**	**número absoluto**
2.1.24	**Qualificar os serviços de Atenção Domiciliar ampliando a cobertura populacional por Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD).**	**Número de equipes EMAD implantada.**	**2024**	**2**	**número absoluto**	**1**	**2**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Definir territórios prioritários para implantação das novas equipes com base em indicadores epidemiológicos e sociodemográficos							
Ação N.º 2	Elaborar plano de dimensionamento de pessoal e ampliação orçamentária para 02 equipes EMAD							
Ação N.º 3	Adquirir transporte compatível com a necessidade de deslocamento, conforme Portaria GM/MS Nº 3.005 de 2024							
Ação N.º 4	Adquirir equipamentos para acomodação da equipe na sede do SAD (cadeiras, mesas, computadores compatíveis com os sistemas e equipamentos de refrigeração adequada)							

Ação N.º 5	Ampliar a cobertura territorial da Atenção Domiciliar para atendimento das áreas rurais de Parauapebas
Ação N.º 6	Realizar capacitações iniciais para integração dos novos profissionais às diretrizes do SAD
Ação N.º 7	Solicitar habilitação e cofinanciamento federal via programa Melhoria da Atenção Domiciliar
Ação N.º 8	Integrar as equipes EMAD com as ESF, CAPS, Atenção Especializada e Rede de Urgência

OBJETIVO 2.2 - Ampliar e qualificar os serviços que compõe a Rede de Atenção Psicossocial no município, assegurando atenção integral, contínua e humanizada às pessoas com sofrimento mental e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
2.2.1	Adequar/reformar o Centro de Atenção Psicossocial II melhorando a infraestrutura e a capacidade assistencial da Rede de Atenção Psicossocial do município.	CAPS II adequando/reformado	2024	0	número absoluto	Não programado	2	número absoluto
2.2.2	Implantar o Centro de Atenção Psicossocial III ampliando a cobertura assistencial da RAPS.	CAPS III implantado	2024	0	número absoluto	Não programado	1	número absoluto
2.2.3	Realizar a construção do CAPS III atendendo os parâmetros estruturais estabelecidos pelo MS e ANVISA.	Estrutura física CAPS III construído	2024	0	número absoluto	Não programado	1	número absoluto
2.2.4	Implantar e habilitar o Centro de Atenção Psicossocial infanto-Juvenil (CAPSi), qualificando a atenção psicossocial a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico.	CAPSi implantado e habilitado junto ao MS.	2024	0	número absoluto	Não programado	1	número absoluto
2.2.5	Realizar a construção do CAPSi atendendo os parâmetros estruturais estabelecidos pelo MS e ANVISA.	Estrutura física CAPSi construído	2024	0	número absoluto	Não programado	1	número absoluto

2.2.6	**Habilitar e implantar o Centro de Atenção Psicossocial álcool e droga (CAPSad) qualificando a atenção psicossocial a todas as pessoas em situações relacionadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas.**	**CAPSad implantado e habilitado junto ao MS.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.2.7	**Construir o prédio do CAPSad atendendo requisitos e parâmetros estruturais estabelecidos pelo MS e ANVISA.**	**Estrutura física do CAPSad construída.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.2.8	**Ampliar os leitos de saúde mental no município.**	**Número de leitos de saúde mental implantados.**	**2024**	**8**	**número absoluto**	**Não programado**	**4**	**número absoluto**
2.2.9	**Aumentar o número de ações de matriciamento realizadas pelo CAPS com a APS.**	**Percentual de ações de matriciamento do CAPS com a APS**	**2024**	**71%**	**percentual**	**78,25%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Mapear as demandas das equipes da APS e identificar aquelas que ainda estão sem apoio matricial sistemático para acompanhamento.							
Ação N.º 2	Construir cronograma com as ações de matriciamento conforme demandas apresentadas pela APS.							
Ação N.º 3	Adquirir transporte institucional e logística para deslocamento das equipes do CAPS até as unidades da APS.							
Ação N.º 4	Estabelecer ações coletivas conjuntas, quando indicado, entre APS e CAPS							
Ação N.º 5	Monitorar a realização de visitas compartilhadas, quando necessário, entre CAPS e APS.							
Ação N.º 6	Planejar Educação Permanente para as equipes da APS em temas prioritários (saúde mental, abordagem de sofrimento psíquico, manejo de casos leves e moderados, prevenção do suicídio, acolhimento, uso de substâncias, cuidado compartilhado)							
2.2.10	**Ampliar cobertura de serviços de saúde mental.**	**Percentual da população com acesso a serviços de saúde mental**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**20%**	**40%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar diagnóstico situacional da cobertura de saúde mental no município, utilizando dados do Prontuário Eletrônico vigente.							
Ação N.º 2	Identificar a população de referência e estimar a demanda potencial por serviços de saúde mental conforme parâmetros do Ministério da Saúde.							
Ação N.º 3	Fortalecer a articulação entre o CAPS II e a Atenção Primária à Saúde (APS), conforme diretrizes da RAPS.							
Ação N.º 4	Manter a estratégias de matriciamento em saúde mental junto às equipes da APS.							

Ação N.º 5	Ampliar o acesso às ações de saúde mental no território, incluindo atendimentos individuais e coletivos.							
Ação N.º 6	Qualificar os registros em saúde mental no sistema eletrônico vigente, visando melhoria dos indicadores e monitoramento.							
Ação N.º 7	Monitorar e avaliar periodicamente os indicadores de cobertura em saúde mental, conforme parâmetros do Ministério da Saúde.							
2.2.11	**Implantar/habilitar 01 Centro de Convivência e Cultura (CECO III).**	**Centro de Convivência e Cultura implantado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

OBJETIVO 2.3: Estruturar, ampliar e qualificar a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência no município, assegurando atenção integral, acessível e contínua às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA), em articulação com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
2.3.1	**Habilitar o Centro Especializado em Reabilitação CER mudando a modalidade II para IV, ampliando a capacidade assistencial da Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência.**	**Modalidade do CER IV habilitado junto ao MS.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**número absoluto**	**1**
2.3.2	**Realizar a construção do CER IV atendendo os pré-requisitos estruturais estabelecidos pelo MS e órgão sanitários,**	**CER IV construído**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.3.3	**Realizar a construção e habilitação da oficina ortopédica fixa ampliando o acesso e a qualidade da assistência no município.**	**Oficina ortopédica construída.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

2.3.4	**Adquirir frota de transporte sanitário adaptado, com acessibilidade para cadeirantes e usuários com mobilidade reduzida, destinado ao atendimento do CER.**	**Número de veículos adaptados adquiridos para o CER.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.3.5	**Aderir ao incentivo financeiro federal de custeio para o Centro Especializado em Reabilitação (CER II) habilitado na modalidade de reabilitação intelectual, qualificando e ampliando a oferta de atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).**	**CER II Modalidade Reabilitação Intelectual (TEA) habilitado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.3.6	**Aderir aos incentivos financeiros federais destinado ao custeio de transporte sanitário adaptado para pessoa com deficiente vinculado ao CER II.**	**Número de veículos de transporte sanitário adaptado habilitados para atendimento às pessoas com deficiência.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**2**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Identificar programas federais de financiamento destinados ao transporte sanitário adaptado.							
Ação N.º 2	Elaborar proposta técnica para adesão ao incentivo financeiro.							
Ação N.º 3	Registrar e encaminhar solicitação de adesão ao Ministério da Saúde.							
Ação N.º 4	Estruturar plano para o transporte sanitário para usuários do CER.							
Ação N.º 5	Garantir uso prioritário do transporte para pacientes com deficiência e mobilidade reduzida.							
2.3.7	**Aumentar os procedimentos de reabilitação executados no CER II e SAD.**	**Número total de procedimentos de reabilitação realizados de acordo com a Nota Técnica Nº15/2024 CGSPD/DAET/SAES/MS.**	**2024**	**25.100**	**número absoluto**	**29.504**	**42.687**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Ampliar a oferta de atendimentos de reabilitação nas áreas física, auditiva, visual e intelectual, de acordo com a demanda identificada							
Ação N.º 2	Realizar diagnóstico da demanda reprimida							
Ação N.º 3	Reorganizar e otimizar os fluxos de acesso e agendamento de usuários para os serviços de reabilitação, reduzindo o tempo de espera e evitando o absenteísmo							
Ação N.º 4	Prover a manutenção de equipamentos, mobiliários e materiais específicos de reabilitação							
Ação N.º 5	Implementar protocolos de atendimento e acompanhamento terapêutico, padronizando condutas e otimizando o tempo de reabilitação por usuário							
Ação N.º 6	Ampliar o monitoramento dos indicadores em reabilitação, utilizando sistemas de informação (como o SIA/SUS) para acompanhamento contínuo da meta.							

2.3.8	**Realizar articulação interfederativa com o Governo do Estado do Pará para viabilizar a implantação do Núcleo Estadual de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA) no município.**	**Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista implantado.**	**2024**	**3150**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.3.9	**Implantar e habilitar junto ao Ministério da Saúde Equipe Assistencial de Cuidados Paliativos (EACP)**	**Número de Equipe Assistenciais de Cuidados Paliativos (EACP) implantados e habilitadas**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.3.10	**Implantar e habilitar junto ao Ministério da Saúde Equipe Matricial de Cuidados Paliativos (EMCP)**	**Número de Equipe Matricial de Cuidados Paliativos (EMCP) implantados e habilitados**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

OBJETIVO 2.4: Implementar o Plano Municipal de Redução de Fila ampliando e qualificando o acesso da população aos serviços de atenção ambulatorial especializada, diminuindo o tempo de espera para consultas, exames e procedimentos, por meio da organização da oferta, fortalecimento da regulação e adesão às estratégias do Programa Agora Tem Especialistas.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
2.4.1	**Ampliar e reestruturar a infraestrutura física da Policlínica Municipal, adequando a capacidade instalada à demanda assistencial da atenção ambulatorial especializada.**	**Policlínica ampliada e reestruturada.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.4.2	**Reformar a Policlínica Municipal qualificando a infraestrutura física e melhorando as condições de trabalho e de atendimento à população.**	**Policlínica reformada.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**2**	**número absoluto**
2.4.3	**Reduzir progressivamente o tempo médio de espera para consultas especializadas prioritárias (neurologia, cardiologia, ginecologia e ortopedia, reumatologia e endocrinologia) reguladas pelo município.**	**Tempo médio de espera para consultas especializadas prioritárias reguladas.**	**2024**	**125**	**dias**	**105**	**≤ 45 dias**	**dias**

Ação N.º 1	Ampliar a oferta de consultas nas especialidades prioritárias (neurologia, cardiologia, ginecologia, ortopedia, reumatologia e endocrinologia) na Policlínica Municipal.							
Ação N.º 2	Reorganizar as agendas dos profissionais das especialidades prioritárias, otimizando a utilização dos horários disponíveis para atendimento.							
Ação N.º 3	Avaliar a necessidade de ampliação da carga horária ou contratação complementar de profissionais especialistas conforme demanda assistencial.							
Ação N.º 4	Implantar estratégias para redução do absenteísmo nas consultas especializadas, incluindo confirmação prévia de consultas e reorganização das vagas não utilizadas.							
Ação N.º 5	Ampliar a realização de atendimentos multiprofissionais e atividades de cuidado compartilhado que contribuam para resolutividade das demandas especializadas.							
Ação N.º 6	Otimizar os fluxos internos de atendimento na Policlínica para melhorar a produtividade assistencial							
2.4.4	**Implantar as modalidades de Ofertas de Cuidados Integrados (OCI's) executadas nos serviços da rede própria, ou credenciadas.**	**OCI's implantadas**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**4**	**6**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar levantamento das necessidades assistenciais prioritárias do município para definição das modalidades de OCIs a serem implantadas.							
Ação N.º 2	Definir e formalizar as modalidades de Ofertas de Cuidados Integrados (OCI's) a serem implantadas na rede municipal.							
Ação N.º 3	Elaborar protocolos assistenciais e fluxos de encaminhamento e contrarreferência para execução das OCIs.							
Ação N.º 4	Realizar análise e conversão progressiva das filas de consultas e exames em Ofertas de Cuidados Integrados (OCI).							
Ação N.º 5	Mapear serviços da rede própria e da rede complementar aptos a executar as OCIs..							
Ação N.º 6	Formalizar demanda para credenciamento de serviços especializados, quando necessário, para execução das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI's), garantindo a ampliação da capacidade assistencial da rede municipal.							
Ação N.º 7	Capacitar profissionais da rede municipal e serviços credenciados quanto aos fluxos assistenciais e critérios de encaminhamento das OCIs.							
Ação N.º 8	Implantar as modalidades de OCI nos serviços da rede própria e credenciada.							
Ação N.º 9	Monitorar a execução das OCIs e avaliar os resultados assistenciais.							
2.4.5	**Ampliar a realização de exames com finalidade diagnóstica por imagem realizados na rede própria e contratualizada, priorizando a redução de filas.**	**Percentual de exames diagnósticos especializados realizados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**60%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar levantamento da demanda reprimida e do tempo de espera para exames de diagnóstico por imagem no município.							
Ação N.º 2	Mapear a capacidade instalada da rede própria e da rede contratualizada para realização de exames de imagem.							
Ação N.º 3	Ampliar a oferta de exames de imagem na rede própria mediante reorganização das agendas e ampliação de turnos de atendimento.							

Ação N.º 4	Formalizar demanda para credenciamento ou contratação de serviços especializados para realização de exames de diagnóstico por imagem, conforme necessidade assistencial.							
Ação N.º 5	Reorganizar os fluxos de solicitação, autorização e agendamento de exames de diagnóstico por imagem por meio da regulação municipal, com elaboração e implantação de protocolos clínicos para solicitação e priorização dos exames.							
2.4.6	**Ampliar progressivamente a oferta de cirurgias eletivas na rede própria, referenciada e/ou contratualizada, com foco na redução da fila de cirurgia eletiva.**	**Número de cirurgias eletivas realizadas**	**2024**	**S/I**	**número absoluto**	**1800**	**6.900**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Elaborar o plano municipal de redução de filas e submetê-lo à pactuação na CIB estadual.							
Ação N.º 2	Fortalecer a atuação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HGP							

OBJETIVO 2.5 Qualificar a atenção materno-infantil na média e alta complexidade, garantindo assistência integral à gestante, ao parto, ao puerpério e ao recém-nascido fortalecendo a Rede Alyne no município e a integração com os demais pontos de atenção à Saúde.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
2.5.1	**Reestruturar e habilitar o Ambulatório de Gestação e Puerpério de Alto Risco – AGPAR ampliando o acesso ao pré-natal de alto risco e o cuidado compartilhado com APS.**	**AGPAR reestruturado e habilitado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.5.2	**Implantar e habilitar o Ambulatório de seguimento do recém-nascido e da criança egressos de unidade neonatal - A-SEG qualificando o cuidado ao recém-nascido de risco, compartilhado com a APS.**	**A-SEG implantado e qualificado**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.5.3	**Realizar consulta de pré-natal de alto risco.**	**Proporção de consultas de pré-natal de alto risco confirmadas.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**80%**	**80%**	**percentual**

Ação N.º 1	Manter a oferta de consultas especializadas para acompanhamento de gestantes de alto risco na Policlínica Municipal, com qualificação do processo de registro e codificação dos procedimentos no SIA/SUS, garantindo a correta identificação das consultas de pré-natal de alto risco.							
2.5.4	**Ampliar a realização dos exames laboratoriais de pré-natal preconizados para gestantes de risco habitual e alto risco.**	**Proporção de gestantes com exames laboratoriais preconizados para o pré-natal avaliados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**80%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Identificar o número de gestantes de risco habitual e alto risco e a demanda mensal de exames.							
Ação N.º 2	Mapear a capacidade instalada do laboratório central de Parauapebas.							
Ação N.º 3	Viabilizar a oferta dos exames preconizados pelo Ministério da Saúde para as gestantes.							
Ação N.º 4	Fazer formalização de solicitação de demanda para serviços de laboratórios privados, insumos e equipamentos para ampliação da oferta, quando necessário.							
Ação N.º 5	Fortalecer pontos de coleta de exames nas Unidade Básicas de Saúde (UBS).							
Ação N.º 6	Proporcionar agendamento ágil e prioritário para gestantes.							
Ação N.º 7	Realizar reuniões periódicas com a APS para avaliação e ajuste das ações.							
2.5.5	**Ampliar a realização dos exames de imagem (ultrassom obstétrica) preconizado para gestantes de risco habitual e alto risco.**	**Proporção de gestantes com pelo menos 01 ultrassom obstétrica avaliada.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**80%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Ampliar a oferta mensal de ultrassonografia obstétrica na rede municipal.							
Ação N.º 2	Garantir realização de exames dentro do período gestacional recomendado.							
Ação N.º 3	Formalizar demanda para credenciamento de serviços privados para realização de ultrassonografia obstétrica.							
Ação N.º 4	Organizar fluxo prioritário para gestantes acompanhadas no ambulatório de alto risco.							
2.5.6	**Aumentar a proporção de parto normal no SUS.**	**Proporção de parto normal no SUS.**	**2024**	**52%**	**percentual**	**53,95%**	**59,80%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Promover educação em saúde para gestantes sobre os benefícios e segurança do parto normal							
Ação N.º 2	Implantar grupos de preparação para o parto e nascimento nas UBS e Maternidade Municipal.							
Ação N.º 3	Capacitar profissionais da rede municipal para assistência ao parto humanizado.							
Ação N.º 4	Incentivar a atuação de enfermeiros obstetras na APS e Maternidade Municipal.							
Ação N.º 5	Fortalecer a adoção de práticas baseadas em evidências na assistência ao parto na maternidade municipal.							

Ação N.º 6	Utilizar a classificação de Robson na maternidade municipal para implementação de estratégias para redução de cesarianas.							
Ação N.º 7	Manter atualizado protocolo clínico obstétrico da maternidade municipal.							
2.5.7	**Habilitar a Maternidade do HGP em Gestação de Alto Risco.**	**Maternidade do HGP habilitada em Gestação de Alto Risco.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.5.8	**Implantar e habilitar leitos de terapia intensiva neonatal.**	**UTINeo implantada e habilitada**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**10**	**número absoluto**
2.5.9	**Implantar e habilitar 5 leitos de UCI Neonatal Canguru.**	**UCI Neonatal Canguru implantada e habilitada (05 leitos).**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**5**	**número absoluto**
2.5.10	**Manter os 10 leitos de UCI Neonatal Convencional.**	**UCI Neonatal Convencional funcionando**	**2024**	**10**	**Leitos**	**10**	**10**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Garantir a manutenção da estrutura física adequada e ambiência da unidade.							
Ação N.º 2	Garantir a realização de ecocardiograma beira leito.							
Ação N.º 3	Garantir a realização de ultrassonografia transfontanela.							
Ação N.º 4	Assegurar funcionamento contínuo dos equipamentos e reposição quando necessário.							
Ação N.º 5	Manter quantitativo adequado de recursos humanos qualificados para assistência neonatal.							
Ação N.º 6	Promover educação permanente da equipe em neonatologia.							
Ação N.º 7	Estimular as boas práticas do método canguru.							
Ação N.º 8	Atualizar e monitorar protocolos assistenciais e de segurança do paciente.							
Ação N.º 9	Proporcionar acesso contínuo ao suporte diagnóstico e terapêutico.							
Ação N.º 10	Monitorar indicadores assistenciais (taxa de ocupação, infecção, transferências, mortalidade).							
Ação N.º 11	Manter atualização regular dos dados no **CNES.**							
Ação N.º 12	Assegurar cumprimento das normas sanitárias e funcionamento da CCIH.							
Ação N.º 13	Monitorar indicadores assistenciais (taxa de ocupação, infecção, transferências, mortalidade)							
Ação N.º 14	Proporcionar as triagens neonatais obrigatórias de acordo com a Orientação do ministério da Saúde (triagem metabólica, auditiva, oximetria de pulso, reflexo vermelho e o teste da linguinha).							

2.5.11	**Reestruturar e habilitar o CPNi tipo II com 5 PPP.**	**CPNi tipo II, com 5 PPP habilitados.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**5**	**número absoluto**
2.5.12	**Implantar e habilitar a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera.**	**Casa da Gestante, Bebê e Puérpera implantada e habilitada.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.5.13	**Construção da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera.**	**Casa da Gestante, Bebê e Puérpera construída.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.5.14	**Realizar articulação interfederativa com o Governo Federal para construção de uma Maternidade para o município.**	**Maternidade construída**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.5.15	**Habilitar o Banco de Leite Humano do HGP.**	**Banco de Leite Humano habilitado**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

OBJETIVO 2.6 – Estruturar, ampliar e qualificar a rede e os serviços de média e alta complexidade, assegurando retaguarda assistencial resolutiva à Atenção Primária e à Atenção Especializada em conformidade as redes de atenção à saúde.

Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			
2.6.1	**Assegurar o funcionamento contínuo e qualificado dos serviços da Atenção Especializada em Saúde por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços de manutenção necessárias para realização das atividades.**	**Percentual de serviços da Atenção Especializada abastecidos regularmente com materiais de consumo e serviços de manutenções essenciais.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**80%**	**95%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar levantamento periódico das necessidades de materiais de consumo dos serviços da Atenção Especializada.							
Ação N.º 2	Planejar e executar processos de solicitação de demanda para a aquisição de insumos e materiais necessários ao funcionamento dos serviços.							
Ação N.º 3	Formalizar solicitação de demanda para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e infraestrutura.							

Ação N.º 4	Monitorar o uso e controle de estoque de materiais.							
Ação N.º 5	Garantir conformidade com normas sanitárias estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.							
2.6.2	**Assegurar a disponibilidade de frota de veículos dimensionada como necessária para atender às demandas operacionais da Atenção Especialidade em Saúde.**	**Percentual de veículos disponíveis em relação à frota necessária planejada.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**≥90%**	**≥90%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Realizar diagnóstico da necessidade de veículos para suporte às atividades da Atenção Especializada.							
Ação N.º 2	Planejar e formalizar solicitação de demanda para a aquisição ou locação de veículos conforme necessidade do serviço.							
Ação N.º 3	Formalizar solicitação de demanda para a manutenção preventiva e corretiva da frota existente.							
Ação N.º 4	Capacitar motoristas para transporte seguro de pacientes e equipes de saúde.							
Ação N.º 5	Assegurar conformidade com normas de transporte sanitário estabelecidas pelo Ministério da Saúde.							
2.6.3	**Promover aquisição/ampliação de frota destinada ao transporte sanitário eletivo para os usuários da rede especializada (SAD, policlínica etc.).**	**Número de ambulâncias adquiridas**	**2024**	**S/I**	**número absoluto**	**Não programado**	**4**	**número absoluto**
2.6.4	**Qualificar as estruturas da Atenção Especializada à Saúde por meio da aquisição de bens permanentes (equipamentos, mobiliário e etc.) necessárias para realização das atividades.**	**Percentual de serviços da Atenção Especializada com equipamentos, mobiliários e bens permanentes adequados às suas atividades.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**75%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar levantamento das necessidades de equipamentos e mobiliários dos serviços especializados.							
Ação N.º 2	Realizar levantamento da necessidade e formalizar solicitação de demanda para a aquisição de bens permanentes.							
Ação N.º 3	Acompanhar processos de compra conforme legislação vigente.							
Ação N.º 4	Instalar e disponibilizar equipamentos necessários ao funcionamento dos serviços especializados.							
Ação N.º 5	Realizar capacitação dos profissionais para utilização adequada dos equipamentos.							
Ação N.º 6	Formalizar solicitação de demanda para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos adquiridos.							
2.6.5	**Implantar o Centro de Referência à Saúde da Mulher**	**Centro de Referência a Saúde da Mulher implantado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

2.6.6	**Aumentar o número de consultas especializadas mensais realizadas na Policlínica.**	**Número de consultas especializadas realizadas na Policlínica**	**2024**	**3150**	**número absoluto**	**3.544**	**4.725**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Ampliar o quadro de profissionais especialistas por meio de novos contratos ou credenciamentos							
Ação N.º 2	Reorganizar e otimizar as agendas de atendimento, reduzindo o número de faltas e melhorando o aproveitamento das vagas disponíveis							
Ação N.º 3	Realizar mutirões de consultas especializadas, priorizando especialidades com maior demanda reprimida							
Ação N.º 4	Promover capacitação e educação permanente para profissionais, visando aprimorar a gestão de filas e o fluxo de atendimento							
Ação N.º 5	Ampliar a oferta de especialidades médicas e serviços de apoio diagnóstico conforme perfil epidemiológico							
Ação N.º 6	Fortalecer a articulação entre Atenção Básica e Policlínica, com protocolos de referência e contrarreferência padronizados							
Ação N.º 7	Monitorar mensalmente os indicadores, com relatórios de consultas realizadas e taxa de absenteísmo							
Ação N.º 8	Adequar a infraestrutura física e tecnológica da Policlínica para comportar o aumento da demanda e garantir qualidade no atendimento							
Ação N.º 9	Desenvolver ações de comunicação e mobilização social, informando a população sobre a ampliação dos serviços e a importância do comparecimento às consultas agendadas							
2.6.7	**Construir um Hemonúcleo em articulação interfederativa com o Estado do Pará.**	**Serviço de sangue e hemoderivados implantado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.6.8	**Ampliar a realização de exames laboratoriais em análise clínica garantindo acesso e qualidade em tempo oportuno**	**Percentual de exames laboratoriais de análises clínicas realizados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**60%**	**≥80%**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Formalizar solicitação de demanda para aquisição de insumos, reagentes e equipamentos laboratoriais necessários.							
Ação N.º 2	Qualificar a equipe técnica responsável pelos exames laboratoriais.							
Ação N.º 3	Implantar protocolos de qualidade e controle dos exames.							
Ação N.º 4	Fortalecer a articulação entre Atenção Primária à Saúde e serviços laboratoriais para agilizar a coleta e entrega de resultados.							
Ação N.º 5	Monitorar indicadores de tempo de resposta e qualidade dos exames.							
Ação N.º 6	Elaborar o projeto arquitetônico conforme normas da Anvisa e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.							
Ação N.º 7	Articular com a APS para a informatização das UBSs com sistema laboratorial.							
Ação N.º 8	Ampliar a oferta de coletas domiciliares, reduzindo tempo de espera.							

2.6.9	**Ampliar a realização dos exames de mamografia de rastreamentos para mulheres de 50 a 74 anos**	**Percentual de exames de mamografia de rastreamento realizado em mulheres de 50 a 74 anos**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**30%**	**≥60%**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Capacitar equipes de Saúde da Família sobre rastreamento do câncer de mama e fluxos de encaminhamento.							
Ação N.º 2	Assegurar manutenção e funcionamento do mamógrafo existente, evitando paralisações por falhas técnicas.							
Ação N.º 3	Mapear a cobertura atual de mamografias por unidade de saúde e identificar áreas com menor acesso.							
Ação N.º 4	Orientar sobre atualização do cadastro de mulheres de 50 a 74 anos nas equipes de Saúde da Família.							
Ação N.º 5	Articular com a APS sobre importância de busca ativa domiciliar por ACS das mulheres que nunca realizaram mamografia.							
Ação N.º 6	Fortalecer o Outubro Rosa como mês de intensificação das ações, com metas locais de realização de exames.							
Ação N.º 7	Articular com a APS para o agendamento automático do exame para mulheres de 50 a 74 anos durante consultas na APS.							
2.6.10	**Ampliar a realização de exames citopatológico em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos.**	**Percentual de exames citopatológicos realizados em mulheres de 25 a 64 anos.**	**2024**	**S/I**	**número absoluto**	**60%**	**≥80%**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Mapear áreas com baixa cobertura e maior vulnerabilidade.							
Ação N.º 2	Assegurar fluxo adequado para encaminhamento e acompanhamento de resultados alterados.							
Ação N.º 3	Capacitar profissionais de saúde na coleta adequada do exame citopatológico.							
Ação N.º 4	Formalizar demanda para solicitação de insumos para realização desses exames.							
Ação N.º 5	Assegurar transporte adequado das lâminas para o laboratório.							
Ação N.º 6	Articular com a APS a identificação do número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos por território/equipe para a realização desse exame.							
2.6.11	**Realizar articulação interfederativa com o Estado do Pará e Ministério da Saúde para construção de Hospital Regional de Alta Complexidade no município.**	**Hospital Regional de Alta Complexidade construído.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
2.6.12	**Informatizar os processos de trabalho das unidades assistências e administrativas do HGP.**	**Percentual de Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado no HGP**	**2024**	**60%**	**Percentual**	**65%**	**95%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Mapear e priorizar os processos assistenciais e administrativos a serem informatizados							
Ação N.º 2	Monitorar indicadores de desempenho do sistema implantado							

Ação N.º 3	Elaborar relatório periódico							
2.6.13	**Aumentar os protocolos implantados nas unidades do Hospital Geral de Parauapebas.**	**Taxa de Protocolos Implantados na Instituição**	**2024**	**60%**	**Percentual**	**80%**	**95%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Acompanhar cronograma de implantação dos Protocolos Gerenciáveis e mensurá-los							
Ação N.º 2	Monitorar os protocolos setoriais a cada 2 anos							
Ação N.º 3	Realizar a manutenção do PAT (Programa Anual de Treinamento) vinculados aos protocolos							
2.6.14	**Reduzir taxa de mortalidade hospitalar no HGP.**	**Taxa de Mortalidade Institucional**	**2024**	**3,8**	**percentual**	**3,8**	**3,5**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar as análises de 100% dos óbitos através da Comissão de Revisão de Óbito (CRO) e CMMIF (Comissão de Mortalidade Materno Infantil)							
Ação N.º 2	Acompanhar as ações da CRO e CMMIF							
Ação N.º 3	Assegurar a cultura multiprofissional na linha do cuidado							
Ação N.º 4	Desenvolver o estudo de casos críticos por equipe multiprofissional							
2.6.15	**Reduzir taxa de infecção geral do HGP.**	**Taxa de Infecção Hospitalar**	**2024**	**8%**	**percentual**	**≤7,5%**	**≤5%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar cultura de vigilância e cultura de paciente							
Ação N.º 2	Gerenciar o Protocolo de Higienização das mãos							
Ação N.º 3	Desenvolver campanha de sensibilização dos profissionais para adesão do Adorno Zero no ambiente hospitalar							
2.6.16	**Reduzir o tempo médio de internação hospitalar.**	**Tempo Médio de Internação Hospitalar**	**2024**	**4**	**número absoluto**	**3,8**	**4**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Consolidar protocolos clínicos							
Ação N.º 2	Fortalecer os POPs cirúrgicos e obstétricos para reduzir infecções hospitalares							
2.6.17	**Manter número de evento Sentinela.**	**Número de evento Sentinela mantida em zero.**	**2024**	**4**	**número absoluto**	**0**	**0**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Consolidar a cultura de segurança do paciente, fortalecendo práticas seguras e preventivas nos processos assistenciais.							
2.6.18	**Realizar articulação interfederativa para Implantação de serviços de hemodinâmica no município no HGP ou rede credenciada.**	**Serviço de Hemodinâmica implantado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

2.6.19	**Ampliar a capacidade instalada de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) no município.**	**Número de cadeiras de hemodiálise habilitadas.**	**2024**	**10**	**número absoluto**	**37**	**37**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar levantamento da demanda municipal de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) em estágio avançado e da necessidade de terapia renal substitutiva.							
Ação N.º 2	Avaliar a capacidade instalada dos serviços que realizam hemodiálise no município.							
Ação N.º 3	Ampliar a capacidade instalada de hemodiálise mediante ampliação do número de máquinas ou turnos de atendimento, conforme demanda municipal.							
Ação N.º 4	Estruturar e ofertar a modalidade de diálise peritoneal como alternativa à hemodiálise para pacientes com Doença Renal Crônica elegíveis, garantindo avaliação clínica, treinamento do paciente e acompanhamento pela equipe especializada.							
Ação N.º 5	Formalizar demanda para credenciamento ou contratação de serviços especializados para terapia renal substitutiva, conforme necessidade assistencial.							
Ação N.º 6	Fortalecer a linha de cuidado da Doença Renal Crônica no município, articulando APS, atenção especializada e serviços de TRS.							
Ação N.º 7	Organizar fluxo para realização de fístula arteriovenosa em pacientes com DRC estágio 4 e 5, que são acompanhados no Ambulatório Pré-Dialítico, antes do início da hemodiálise.							
2.6.20	**Ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento oncológico no município, mediante ampliação da oferta de atendimentos com base nos tipos de câncer de maior incidência na região.**	**Percentual tratamento de câncer atendidos no serviço oncológico credenciado.**	**2024**	**28,57%**	**percentual**	**28,57%**	**≥60%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar análise epidemiológica dos tipos de cânceres de maior incidência no município para planejamento de ações e serviços de saúde direcionados à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.							
Ação N.º 2	Ampliar a oferta de consultas especializadas para investigação de casos suspeitos de câncer na rede própria ou contratualizada, reduzindo o tempo entre a suspeita e o diagnóstico.							
Ação N.º 3	Ampliar a oferta de exames e procedimentos diagnósticos relacionados à investigação oncológica na rede própria ou contratualizada, reduzindo o tempo entre a suspeita e o diagnóstico.							
Ação N.º 4	Ampliar a oferta de tratamento oncológico através do credenciamento ou contratação de serviços de saúde.							
Ação N.º 5	Implantar as linhas de cuidado em oncologia com definição de fluxos assistenciais entre os pontos de atenção da rede.							
Ação N.º 6	Implantar fluxos de regulação prioritária para pacientes com suspeita e diagnóstico de câncer.							
Ação N.º 7	Garantir a navegação dos pacientes dentro da rede desde a suspeita do câncer até o início do tratamento, visando reduzir o tempo de espera e garantir melhor adesão do paciente ao tratamento.							
2.6.21	**Capacitar os profissionais da DAES visando à Qualidade da Assistência em Saúde no município.**	**Percentual de profissionais da DAES capacitados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**50%**	**≥80%**	**percentual**

Ação N.º 1	Realizar levantamento das necessidades de capacitação dos profissionais vinculados à DAES.							
Ação N.º 2	Formalizar solicitação de demanda para serviços de capacitações sobre temas relacionados à qualidade da Assistência em Saúde no município.							
Ação N.º 3	Elaborar e executar um Plano Anual de Educação Permanente, contemplando cursos, oficinas, treinamentos e atualizações técnicas voltadas à qualificação da assistência em saúde.							
Ação N.º 4	Estimular a participação dos profissionais em eventos científicos, seminários e congressos relacionados à gestão e assistência em saúde.							
2.6.22	**Promover a qualificação dos profissionais da Rede de Urgência e Emergência por meio da realização de cursos especializados em atendimento pré-hospitalar e suporte avançado à vida (AMLS; ACLS; PHTLS; BLS e Controle de Hemorragias).**	**Percentual de profissionais da Rede de Urgências e Emergência capacitados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**50%**	**≥80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar diagnóstico das necessidades de capacitação dos profissionais que atuam na Rede de Urgência e Emergência (SAMU, UPA, hospitais e unidades de apoio).							
Ação N.º 2	Formalizar solicitação de demanda para contração de serviços que realizem cursos de certificação em: AMLS (Advanced Medical Life Support); ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); PHTLS (Prehospital Trauma Life Support); BLS (Basic Life Support) e Controle de Hemorragias e atendimento inicial ao trauma.							
Ação N.º 3	Atualizar periodicamente os protocolos de atendimento da Rede de Urgência e Emergência conforme diretrizes nacionais e internacionais.							
Ação N.º 4	Monitorar e avaliar o impacto das capacitações, analisando indicadores como tempo de resposta, qualidade do atendimento e desfechos assistenciais.							
Ação N.º 5	Manter banco de dados atualizado dos profissionais capacitados, incluindo validade das certificações.							
REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO								
DIRETRIZ 3: Fortalecer os mecanismos de regulação, controle e avaliação dos serviços de saúde no âmbito municipal, garantindo o acesso ordenado, equitativo e oportuno aos exames, consultas especializadas, cirurgias eletivas e serviços especializados, com monitoramento contínuo de desempenho e redução de filas.								
OBJETIVO 3.1: Organizar, monitorar e qualificar os processos de regulação, avaliação e auditoria da rede de saúde, assegurando o acesso eficiente aos serviços conforme prioridades clínicas, eficiência no uso de recursos e cumprimento das diretrizes do SUS.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			

3.1.1	**Reestruturar a Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação (DIRCA) em conformidade com a Política Nacional de Regulação do SUS.**	**Complexo Regulador instituído por ato normativo**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar o levantamento da capacidade instalada de oferta de cuidado na RAS (Rede própria e prestadores SUS), para contratualização de ofertas em conformidade com a nova modelagem da PNR e o Programa Agora Tem Especialista, braço da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES);							
Ação N.º 2	Elaborar Notas Técnicas de estruturação dos setores da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação – DIRCA, em conformidade com a Nova Política de Regulação do Sistema de Saúde, compreendendo ser a regulação uma função de gestão, em seus aspectos gerenciais, administrativos, tecnológicos e clínico.							
Ação N.º 3	Publicar um ato oficial (decreto ou portaria) que institua legalmente o Núcleo de Gestão e Regulação e o Complexo Regulador Municipal (Ambulatorial e Hospitalar), cumprindo o indicador exato estabelecido para esta meta.							
3.1.2	**Adequar espaço físico atual de funcionamento do Complexo Regulador Municipal, garantindo condições técnicas, tecnológicas e operacionais.**	**Espaço físico adequado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
3.1.3	**Construir o prédio do Complexo Regulador do município atendendo requisitos e parâmetros estruturais estabelecidos pelo MS e em conformidade com a Política Nacional de Regulação do SUS.**	**Estrutura física do Complexo Regulador construído.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
3.1.4	**Adquirir bens permanentes (mobiliário, equipamentos e infraestrutura tecnológica) para o complexo regulador conforme a Política Nacional de Regulação do SUS, até 2028.**	**Percentual de bens permanentes preconizado adquiridos**	**2024**	**0**	**percentual**	**60%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar levantamento físico dos bens atuais e mapear o déficit de mobiliário (cadeiras ergonômicas, mesas) e tecnologia (computadores, monitores duplos) por setor.							
Ação N.º 2	Criar descritivos técnicos robustos para equipamentos de TI (servidores, headsets para regulação, nobreaks) para evitar a aquisição de materiais de baixa qualidade.							
Ação N.º 3	Garantir que cada mesa de regulação tenha dois monitores (essencial para operar o esusregulação em uma tela e prontuários/mapas em outra).							
Ação N.º 4	Adquirir mobiliário para áreas de descanso, copa e sala de reuniões técnicas (importante para o bem-estar dos servidores que atuam em plantões de 12h/24h).							

Ação N.º 5	Substituir 100% dos desktops antigos por máquinas com alta capacidade de processamento e armazenamento em nuvem.							
Ação N.º 6	Instalação de sistemas de climatização central e mobiliário sustentável, visando a eficiência energética do Complexo Regulador.							
Ação N.º 7	Implantar link de internet dedicado e redundante, garantindo que a regulação não pare por falta de sinal.							
Ação N.º 8	Adquirir licenças de softwares de segurança, firewalls e sistemas de backup físico/em nuvem para proteger os dados sensíveis dos pacientes.							
3.1.5	**Implantar/implementar sistema informatizado integrado para gestão da regulação ambulatorial, hospitalar e de urgência, articulado aos sistemas oficiais do SUS.**	**Sistema implantado e operando (Sim/Não)**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Definir as regras de integração (APIs) para que o sistema municipal "leia" e "escreva" dados automaticamente no esus regulação (ambulatorial/hospitalar) e no e-SUS APS, evitando a digitação duplicada.							
Ação N.º 2	Especificar módulos obrigatórios: Gestão de Leitos (censo em tempo real), Gestão de Consultas/Exames, Gestão de Transporte Sanitário e Painel de Indicadores (BI).							
Ação N.º 3	Garantir que o sistema esteja em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com níveis de acesso diferenciados para médicos reguladores, administrativos e gestores.							
Ação N.º 4	Instalar terminais nos hospitais para que a atualização da ocupação de leitos seja feita em tempo real, eliminando a necessidade de planilhas manuais ou ligações telefônicas constantes.							
Ação N.º 5	Realizar a transferência dos dados das filas atuais para o novo sistema, garantindo a integridade do histórico do paciente e a ordem cronológica das solicitações.							
Ação N.º 6	Treinar equipes-chave em cada UBS e Hospital para que saibam inserir solicitações com anexos (exames/laudos), reduzindo as "devoluções" por falta de informação.							
3.1.6	**Implantar protocolos municipais de classificação de risco e priorização, por tipos de demandas regulatórias, alinhada com à Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Especializada, Núcleos Internos de Regulação (NIR) e Núcleo de Gestão do Cuidado (NGC).**	**Percentual de protocolos implantados e pactuados com os pontos da rede.**	**2024**	**0**	**percentual**	**50%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Elaborar Matrizes de Pontuação por Especialidade, com a criação de critérios de pontuação (score) baseados em sinais, sintomas e exames para as 10 especialidades com maior fila, permitindo que o sistema classifique automaticamente em Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho.							
Ação N.º 2	Designar uma equipe técnica de reguladores médicos para elaboração dos protocolos de classificação de risco, priorização, risco vulnerabilidade por demanda.							
Ação N.º 3	Estabelecer quais exames básicos e tratamentos prévios a APS deve realizar antes de encaminhar para a Especialidade, evitando que o especialista receba casos que poderiam ser resolvidos na UBS.							

Ação N.º 4	Padronizar os critérios de "Vaga Zero" e transferência prioritária entre hospitais, baseando-se em protocolos tempo-dependentes (AVC, IAM, Trauma).							
Ação N.º 5	Realizar reuniões mensais entre médicos reguladores da DIRCA e médicos da APS para discutir casos "devolvidos" por falta de critério, educando a ponta sobre os novos protocolos.							
Ação N.º 6	Dar transparência à rede (APS e Hospitais) sobre qual o tempo médio de atendimento para cada cor de classificação, alinhando as expectativas do paciente.							
Ação N.º 7	Criar indicadores que mostrem quais Unidades Básicas estão encaminhando com maior precisão técnica.							
3.1.7	**Implantar fluxos regulatórios padronizados integrados à Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Especializada, Núcleos Internos de Regulação (NIR) e Núcleo de Gestão do Cuidado (NGC).**	**Percentual de fluxos regulatórios padronizados e implantados**	**2024**	**0**	**percentual**	**50%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Dar suporte as equipes do atual Núcelo Interno de Regulação (hospitalar) para melhorar a comunicação com o hospital geral e conveniados ao SUS.							
Ação N.º 2	Criar um grupo de trabalho com representantes da APS, DIRCA, NIRs hospitalares e o Núcleo de Gestão do Cuidado (NGC) para pactuar as responsabilidades de cada ponto da rede.							
Ação N.º 3	Desenvolver protocolos que definam o caminho exato do paciente para patologias de alto impacto (ex: Diabetes Mellitus, Hipertensão, Oncologia e Pré-natal de Alto Risco).							
Ação N.º 4	Normatizar que o NIR é responsável pela regulação intra-hospitalar (giro de leito) e o NGC pela gestão do caso complexo (garantir que o paciente tenha suporte após a alta) e seguimento na APS após avaliação ambulatorial.							
Ação N.º 5	Estabelecer um fluxo onde o médico da APS possa tirar dúvidas com o especialista regulador via sistema antes de gerar um encaminhamento, evitando filas desnecessárias.							
Ação N.º 6	Configurar o sistema para que, no momento da internação (via NIR) ou alta, a equipe de Saúde da Família (APS) receba um alerta automático para programar a visita domiciliar.							
Ação N.º 7	Instituir gestão de cuidado e transição a partir do PLANO DE ALTA. O NGC deve validar, junto ao NIR, o plano de cuidados pós-hospitalar 24h antes da alta, enviando as orientações diretamente para a enfermeira da UBS de referência.							
3.1.8	**Implantar protocolo municipal de transição do cuidado, garantindo contrarreferência registrada em das altas hospitalares.**	**Percentual de altas com contrarreferência registrada.**	**2024**	**0**	**percentual**	**50%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Criar um grupo de trabalho técnico com participação da APS e AES, para elaboração do protocolo de transição do cuidado.							
Ação N.º 2	Criar um documento técnico que defina o que deve constar obrigatoriamente no sumário de alta (diagnóstico, medicamentos prescritos, exames pendentes e orientações de sinais de alerta).							
Ação N.º 3	Padronizar um modelo (físico ou digital) que seja entregue ao paciente e, simultaneamente, enviado à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.							
Ação N.º 4	Realizar oficinas prática com profissionais da rede de atenção a saúde para utilização do mesmo.							

Ação N.º 5	Apoiar a implementação de Núcleo de Gestão do Cuidado em todas as prestadoras conveniadas ao SUS executantes das ofertas de cuidado integrado-OCI							
3.1.9	**Implantar protocolo municipal de transporte sanitário integrado à regulação, garantindo priorização conforme classificação clínica.**	**Protocolo de transporte sanitário integrado implantado.**	**2024**	**0**	**percentual**	**50%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Criar um documento técnico que defina critérios claros (Ex: Vermelho = saída imediata; Amarelo = até 30 min; Verde = conforme agendamento) para o despacho de viaturas.							
Ação N.º 2	Instituir o protocolo via ato oficial, conferindo à Central de Regulação a autoridade para priorizar o despacho de veículos sobre agendamentos eletivos em casos de urgência.							
Ação N.º 3	Implementar um formulário único (digital ou físico padronizado) onde o médico solicitante já aponte os sinais vitais e a classificação clínica, vinculando o pedido de transporte ao código da autorização do leito.							
Ação N.º 4	Centralizar a gestão de todas as ambulâncias (eletivas e de urgência) em uma única mesa operacional, permitindo que o regulador remaneje veículos conforme a criticidade do momento.							
Ação N.º 5	Estabelecer fluxos fixos de transporte para patologias específicas, reduzindo o tempo de "decisão" sobre qual hospital deve receber o paciente.							
Ação N.º 6	Capacitar 100% dos motoristas, técnicos de enfermagem e reguladores sobre os novos níveis de prioridade do protocolo municipal.							
Ação N.º 7	Criar um grupo técnico para analisar mensalmente casos onde o tempo de transporte possa ter impactado o desfecho clínico, gerando melhorias no protocolo.							
3.1.10	**Monitorar mensalmente as filas reguladas, com emissão de relatório gerencial para a gestão municipal.**	**Percentual de competências monitoradas**	**2024**	**0**	**percentual**	**100%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Criar um modelo de relatório padrão que contenha: Quantitativo por especialidade, Tempo Médio de Espera (TME), Absenteísmo (Faltas) e correlação com a oferta de prestadores.							
Ação N.º 2	Instituir um cronograma rígido para extração de dados dos sistemas reguladores (SISREG ou similar) até o 5º dia útil de cada mês, garantindo que o dado analisado seja recente.							
Ação N.º 3	Comparar mensalmente o crescimento ou redução da fila por especialidade, identificando demandas reprimidas sazonais ou falta de cobertura assistencial específica.							
Ação N.º 4	Realizar "limpezas" periódicas nas filas (call center ou busca ativa) para remover duplicidades, solicitações já resolvidas ou pacientes que não residem mais no município.							
Ação N.º 5	Formalizar o envio do relatório gerencial à Secretaria de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde, destacando as 10 especialidades com maior tempo de espera.							
Ação N.º 6	Apresentar os dados do relatório para os diretores das unidades solicitantes (UBS/UPAs) para ajustar a qualidade das guias e evitar encaminhamentos desnecessários que inflam a fila.							
3.1.11	**Reduzir a taxa de absenteísmo dos procedimentos regulados.**	**Taxa de absenteísmo.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**9,80%**	**≤6%**	**percentual**

Ação N.º 1	Elaborar protocolo que contemple as atividades de comunicação multicanal com paciente (mensagens automáticas no whatsapp, Qrcode no cartão de consulta, entre outros), para reduzir absenteísmo técnico ou institucional							
Ação N.º 2	Promover capacitação com equipes da APS sobre utilização dos recursos do telessaúde (telerregulação assistencial).							
Ação N.º 3	Realizar a qualificação da fila de espera com monitoramento diário pelas equipes da regulação.							
Ação N.º 4	Reduzir o absenteísmo social,atraves da designação de equipe específica para ligar para os pacientes idosos, PCD e pacientes regulados via TFD.							
3.1.12	**Garantir que as solicitações de leitos regulados sejam autorizadas no prazo previsto no protocolo de classificação clínica.**	**Percentual de solicitações autorizadas dentro do prazo.**	**2024**	**0**	**percentual**	**50%**	**≥%90**	**percentual**
Ação N.º 1	Desenvolver painéis de Business Intelligence (BI) que emitam alertas visuais (semáforo) quando uma solicitação atingir 80% do tempo limite previsto no protocolo.							
Ação N.º 2	Realizar reuniões breves (Daily ou Weekly) entre o médico regulador e a gestão para identificar gargalos repetitivos em patologias específicas							
Ação N.º 3	Realizar a revisão e atualização dos Protocolos de Classificação: Atualizar as linhas de cuidado (Cardiologia, Neurologia, etc.) garantindo que os critérios de priorização estejam claros, reduzindo a subjetividade do regulador.							
Ação N.º 4	Estabelecer fluxos automáticos para patologias tempo-dependentes (como AVC e IAM), onde a autorização ocorre por critério clínico imediato, independente da confirmação imediata da logística de transporte.							
Ação N.º 5	Fortalecer os NIRs nos hospitais executores para acelerar a liberação de leitos ociosos e a comunicação imediata da vacância à Central de Regulação.							
Ação N.º 6	Implementar ou ampliar o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) para pacientes de baixa complexidade, liberando leitos hospitalares para as solicitações da regulação.							
Ação N.º 7	Capacitar 100% da equipe de regulação nos protocolos vigentes para evitar reiterações (pedidos de mais informações) que travam o relógio da autorização.							
3.1.13	**Garantir atendimento das solicitações de transporte sanitário classificadas como prioritárias dentro do prazo estabelecido em protocolo.**	**Percentual de transportes atendidos no prazo.**	**2024**	**0**	**percentual**	**50%**	**≥90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Posicionar ambulâncias de suporte em pontos estratégicos (nós de rede) para reduzir o "tempo de deslocamento em vazio" até o paciente.							
Ação N.º 2	Estabelecer um sistema de rodízio e manutenção que garanta que 95% da frota de transporte prioritário esteja operacional 24/7, evitando baixas inesperadas.							
Ação N.º 3	Criar protocolos de higienização rápida (pós-transporte) para que o veículo retorne ao status de "disponível" no menor tempo possível.							
Ação N.º 4	Instalar ou atualizar sistemas de telemetria em 100% da frota para que a Central de Regulação visualize a viatura mais próxima da ocorrência prioritária.							
Ação N.º 5	Automatizar a escala de motoristas e técnicos para garantir que não haja "vazio assistencial" por falta de pessoal qualificado no momento do chamado.							

Ação N.º 6	Estabelecer uma "via rápida" no rádio/sistema para chamados classificados como urgentes, com tempo de saída da base em no máximo 10 minutos após o chamado.							
Ação N.º 7	Treinar 100% dos condutores em protocolos de transporte de pacientes críticos e fluxos de comunicação via rádio.							
Ação N.º 8	Formalizar parcerias com municípios vizinhos ou consórcios de saúde para suporte em casos de picos de demanda que excedam a capacidade local.							
Ação N.º 9	Assegurar o acesso de pessoas com deficiências físicas, auditivas, intelectuais, visuais ou múltiplas aos pontos de atenção, através de transporte sanitário adpatado.							
3.1.14	**Implantar programa permanente de educação continuada em regulação e gestão do acesso, com realização anual de ações formativas.**	**Número de ações formativas realizadas por ano.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**2**	**8**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar o levantamento de Necessidades de Aprendizagem (LNA), com aplicação de questionários anuais aos reguladores e equipes da APS e EAS para identificar as maiores dificuldades (ex: preenchimento de laudos, uso do sistema, critérios de priorização)							
Ação N.º 2	Realizar a atualização de protocolos específicos das especialidades							
Ação N.º 3	Realizar ciclos de oficinas formativas práticas (encontros presenciais e a distancia)							
3.1.15	**Aumentar a taxa de auditoria realizada pelo DIRCA de procedimentos ambulatoriais e hospitalares.**	**Taxa de auditoria dos procedimentos (ambulatorial e hospitalar)**	**2024**	**60%**	**percentual**	**70%**	**≥90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Padronizar "Checklists de Conformidade" para os procedimentos de maior custo e volume (ex: Cirurgias Eletivas, Exames de Alta Complexidade), garantindo que todos os auditores avaliem os mesmos critérios.							
Ação N.º 2	Estabelecer a rotina de conferência obrigatória de uma amostra (ex: 10% a 20%) das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) e Boletins de Produção Ambulatorial (BPA) antes da aprovação do pagamento.							
Ação N.º 3	Realizar treinamento focado em faturamento SUS, codificação de procedimentos (SIGTAP) e preenchimento de laudos médicos para reduzir glosas por erros formais.							
Ação N.º 4	Instituir a presença física ou virtual do auditor nos hospitais durante a internação do paciente, validando a necessidade do procedimento e a qualidade da assistência enquanto ela ocorre.							
Ação N.º 5	Elaborar relatórios com devolutivas às prestadoras de saúde e rede própria.							
Ação N.º 6	Integrar ao sistema de regulação alertas para "Inconsistências de Faturamento" (ex: cobrança de procedimentos incompatíveis com a idade ou sexo do paciente, ou excesso de exames para um mesmo diagnóstico).							
Ação N.º 7	Estruturar um Dashboard que mostre o índice de aprovação e reprovação de faturas por prestador, permitindo que a gestão identifique quais unidades precisam de intervenção ou reorientação técnica.							
Ação N.º 8	Implementar busca ativa (telefônica ou digital) para confirmar com o paciente se o procedimento faturado pelo prestador foi efetivamente realizado e se a qualidade foi adequada.							

3.1.16	**Reduzir as inconsistências no envio de dados da produção do sistema de informação ambulatorial – SIA.**	**Percentual de inconsistências nos registros da produção ambulatorial (SIA)**	**2024**	**S/I**	**Percentual**	**10%**	**30%**	**percentual**
Ação N.º 1	Fortalecer equipe de análise de produção (rede conveniada e MAC)							
Ação N.º 2	Treinar equipe de auditoria, controle e avaliação							
Ação N.º 3	Revisar rotinas de envio de dados							
Ação N.º 4	Realizar capacitações com prestadores do SUS sobre registro e consolidação de informações (rede conveniada e MAC)							
3.1.17	**Garantir acesso oportuno e equitativo ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), estruturando e implantando fluxo regulatório padronizado, com monitoramento sistemático dos processos, assegurando que, no mínimo, 90% das solicitações elegíveis sejam analisadas, autorizadas e encaminhadas dentro do prazo estabelecido em protocolo municipal.**	**Percentual de solicitações de TFD elegíveis analisadas e autorizadas dentro do prazo estabelecido no protocolo municipal.**	**2024**	**S/I**	**Percentual**	**50%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Elaborar o Protocolo Municipal do TFD e posterior publicação de Portaria.							
Ação N.º 2	Criar um guia prático que defina quem tem direito, quais documentos são obrigatórios e os prazos máximos para cada etapa (análise médica, autorização administrativa e agendamento de transporte/ajuda de custo).							
Ação N.º 3	Realizar o treinamento das unidades (APS, AES) sobre o novo fluxo							
Ação N.º 4	Disponibilizar para as UBS e Hospitais um check-list rigoroso para que o processo já chegue à regulação completo, evitando "diligências" que travam o prazo de análise.							
Ação N.º 5	Centralizar o recebimento das solicitações para evitar a dispersão de documentos e permitir o protocolo imediato com número de rastreio para o paciente.							
Ação N.º 6	Implementar a informatização dos processos de TFD, integrando as solicitações ao sistema de regulação municipal, permitindo que o paciente acompanhe o status (análise, autorizado, aguardando transporte) via terminal ou aplicativo.							
Ação N.º 7	Criar um painel gerencial que aponte alertas vermelhos para processos que estejam chegando ao limite do prazo estabelecido no protocolo municipal (Ex: 5 dias para análise prioritária).							

Ação N.º 8	Revisar os contratos de passagens, garantindo que o fator financeiro/logístico não atrase o encaminhamento do paciente já autorizado e as ajudas de custo sejam liberadas em tempo hábil.							
Ação N.º 9	Realizar relatórios trimestrais que cruzem os dados do TFD com o perfil epidemiológico do município, identificando se as autorizações estão atendendo às áreas de maior vulnerabilidade e necessidade clínica.							
Ação N.º 10	Formalizar o grupo de médicos reguladores responsáveis pela análise clínica do TFD, estabelecendo metas semanais de vazão de processos acumulados.							
3.1.18	**Implantar, até o final do quadriênio do PMS, o modelo de Ofertas de Cuidado Integrado (OCI) no âmbito da Regulação Municipal, garantindo que, no mínimo, 80% dos encaminhamentos para Atenção Ambulatorial Especializada das linhas prioritárias ocorram por meio de OCI, com definição de fluxos regulatórios, protocolos pactuados e monitoramento sistemático das filas.**	**Percentual de encaminhamentos para especialidades prioritárias realizados por meio de OCI.**	**2024**	**0**	**Percentual**	**20%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar treinamento inicial sobre o PMAE e a nova modalidade de cuidado na atenção especializada, no primeiro quadrimestre de 2026, com 100% dos médicos generalistas das UBS's							
Ação N.º 2	Implantar as OCI's de Otorrinolaringologia e Oftalmologia até a 2º quadrimestre de 2026							
Ação N.º 3	Implantar as demais OCI's pactuadas até o final do 3º quadrimestre de 2029							
Ação N.º 4	Criar indicadores de processo na implantação das OCI'S, a serem acompanhados pelo Núcleo de Gestão e Regulação (Indicadores de Integração e Governança, Indicadores de Fluxo e Tempestividade e Indicadores de Qualidade da Informação/Continuidade).							
3.1.19	**Implantar rotina permanente de qualificação e depuração da fila de cirurgias eletivas, com revisão periódica das solicitações, assegurando que 80% dos registros sejam atualizados quanto à indicação clínica, condição do paciente e manutenção do interesse na realização do procedimento.**	**Percentual de registros da fila cirúrgica revisados e atualizados no período.**	**2024**	**S/I**	**Percentual**	**20%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Criar um Grupo de Trabalho Interno na Regulação para revisão diária de dados cadastrais e solicitações							
Ação N.º 2	Elaborar o Procedimento Operacional Padrão (POP) de triagem e revisão clínica das solicitações vindas das Unidades básicas de saúde							

Ação N.º 3	Desenvolver um protocolo de suspensão administrativa, a partir da normatização de solicitações que estejam sem atualização de exames ou contato há mais de 12 meses sejam movidas para uma "fila de contingência" até que o paciente compareça à UBS para reavaliação.
Ação N.º 4	Responsabilizar as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) pela atualização bianual das condições clínicas dos seus pacientes que estão na fila de cirurgia, inserindo as notas diretamente no prontuário integrado.
Ação N.º 5	Desenvolver um Dashboard que aponte automaticamente registros que não sofrem interação do regulador há mais de 90 dias, gerando um alerta de "necessidade de depuração".
Ação N.º 6	Analisar as causas das faltas no dia da cirurgia. Se o motivo for "paciente já operado" ou "desistência", retroagir no processo para identificar por que a depuração falhou naquele caso específico.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DIRETRIZ 4: Fortalecer a Assistência Farmacêutica no município de Parauapebas garantindo o acesso a medicamentos e insumos estratégicos, seu uso racional em consonância as necessidades do SUS e bem-estar da população, promovendo educação continuada, inserção e valorização dos profissionais da Assistência Farmacêutica e saúde digital com sistemas de informação e de gerenciamento.

OBJETIVO 4.1: Ampliar o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, promovendo o uso racional, seguro e eficaz e serviços farmacêuticos: qualificando a assistência e cuidado farmacêutico, a educação continuada, a descentralização do sistema de informação, o gerenciamento para os serviços público de saúde do município e o fortalecimento do uso de planta medicinais e fitoterápicos como alternativa terapêutica.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
4.1.1	**Reestruturar e manter ativa a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) no âmbito municipal.**	**CFT legalmente restruturada e ativa.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Articular junto as diretorias a indicação dos membros para compor a equipe multidisciplinar da CFT							
Ação N.º 2	Elaborar e publicar Portaria Municipal de instituição da CFT com as devidas atribuições dos membros							
Ação N.º 3	Elaborar e aprovar o Regimento Interno da CFT							
Ação N.º 4	Realizar oficina de capacitação dos membros da CFT							

Ação N.º 5	Planejar as atividades e cronograma das reuniões da CFT							
Ação N.º 6	Monitorar e avaliar o desempenho da CFT, garantindo periodicidade das reuniões, cumprimento de pautas e atualização regular da REMUME							
4.1.2	**Elaborar e atualizar a cada dois anos a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) em conformidade com Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024), o perfil epidemiológico e assistenciais do município.**	**REMUME elaborada e atualizada conforme a RENAME vigente.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar análise do perfil epidemiológico e do consumo de medicamentos							
Ação N.º 2	Realizar alinhamento técnico com a RENAME 2024 e protocolos clínicos vigentes							
Ação N.º 3	Realizar a elaboração da versão oficial da REMUME							
Ação N.º 4	Realizar a validação da REMUME junto a CMS e publicação no Diário Oficial e Portais oficiais							
Ação N.º 5	Realizar uma ampla divulgação da REMUME junto aos profissionais de saúde e a população							
Ação N.º 6	Realizar a atualização da REMUME a cada 2 anos ou de acordo com a versão atualizada da RENAME							
4.1.3	**Ampliar o acesso aos medicamentos essenciais e insumos estratégicos padronizados na REMUME 2026 nas farmácias das UBS.**	**Percentual de medicamentos e insumos padronizados na REMUME dispensados nas farmácias das UBS.**	**2024**	**20%**	**percentual**	**≥50%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar o Ciclo da Assistência Farmacêutica (Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento e Distribuição/ Dispensação)							
Ação N.º 2	Monitorar quinzenalmente o sistema de gerenciamento e informações (HÓRUS)							
Ação N.º 3	Monitorar os repasses tripartite para Assistência Farmacêutica de acordo com as portarias do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Regional – CIR							
Ação N.º 4	Divulgar quinzenalmente no site da prefeitura e outras mídias digitais os estoques de medicamentos das farmácias do SUS							
Ação N.º 5	Capacitar farmacêuticos e auxiliares de farmácia em boas práticas de armazenamento, controle de validade e dispensação racional de medicamentos							
Ação N.º 6	Fortalecer a integração entre a Assistência Farmacêutica e as equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), visando o uso racional de medicamentos e a otimização da logística de reposição							
Ação N.º 7	Promover reuniões periódicas entre a Diretoria/Gerencias da Assistência Farmacêutica com a Diretoria Administrativa/setor de Compras para alinhamento sobre cronogramas licitatórios e contratos							

Ação N.º 8	Planejar, participar e monitorar os processos licitatórios com base em dados atualizados de consumo, evitando descontinuidade no fornecimento por atrasos ou falhas contratuais							
4.1.4	**Ampliar o abastecimento de medicamentos e insumos farmacêuticos para serviços especializado da MAC e urgência/emergência.**	**Percentual de medicamentos e insumos disponíveis nos serviços especializado da MAC e urgência/emergência conforme protocolos clínicos.**	**2024**	**20%**	**percentual**	**≥50%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar a padronização dos medicamentos de acordo protocolos clínicos e terapêuticos implantados pelas CFT nos serviços especializados da MAC e urgência/emergência							
Ação N.º 2	Realizar aquisição e distribuição de medicamentos e insumo de acordo com a padronização aprovada pela CFT para os serviços especializados da MAC e urgência/emergência							
Ação N.º 3	Realizar articulação com a DAES para funcionamento 24 horas da farmácia da Unidade de Pronto Atendimento – UPA							
Ação N.º 4	Realizar articulação com a DAES para implantação da dispensação individualizada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA							
Ação N.º 5	Monitorar quinzenalmente o sistema de gerenciamento e informações (HÓRUS).							
Ação N.º 6	Planejar e monitorar os processos licitatórios com base em dados atualizados de consumo, evitando descontinuidade no fornecimento por atrasos ou falhas contratuais							
4.1.5	**Ampliar o fornecimento das fórmulas às crianças cadastradas no Programa APLV.**	**Percentual de crianças cadastrada no programa recebendo as fórmulas prescrita.**	**2024**	**27%**	**percentual**	**≥50%**	**75%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar a atualização do cadastro das crianças beneficiárias do Programa APLV, garantindo informações completas sobre diagnóstico, idade, fórmula prescrita, unidade de acompanhamento e período de tratamento							
Ação N.º 2	Solicitar inclusão do Programa de Saúde APLV no Sistema Hórus Básico ao DataSUS							
Ação N.º 3	Monitorar mensalmente a demanda e o consumo médio das fórmulas, utilizando essas informações para subsidiar o planejamento de compras e prevenir desabastecimentos							
Ação N.º 4	Planejar e monitorar os processos licitatórios com base em dados atualizados de consumo, evitando descontinuidade no fornecimento por atrasos ou falhas contratuais							
Ação N.º 5	Estabelecer fluxo de comunicação entre a CAF e responsável pelo programa na APS, para informar sobre entregas, estoques e eventuais atrasos no fornecimento							
Ação N.º 6	Realizar articulação junto a CIR/ CIB para regulamentação das competências do financiamento das fórmulas incorporadas pela CONITEC							
4.1.6	**Ampliar o abastecimento de fraldas aos pacientes com cadastro ativo na Rede de Cuidado à Pessoas com Deficiência – RCPD. Em consonância com o protocolo municipal.**	**Percentual de pacientes ativos da RCPD com recebimento regular de fraldas.**	**2024**	**18%**	**percentual**	**≥50%**	**75%**	**percentual**

Ação N.º 1	Atualizar o cadastro dos usuários beneficiários do Programa de Fornecimento de Fraldas para garantir a aquisição e fornecimento em quantidades de acordo com protocolo municipal							
Ação N.º 2	Solicitar inclusão do Programa de Saúde Fraldas no Sistema Hórus Básico ao DataSUS							
Ação N.º 3	Monitorar mensalmente a demanda e o consumo médio das fraldas, utilizando essas informações para subsidiar o planejamento de compras e prevenir desabastecimentos							
Ação N.º 4	Planejar e monitorar os processos licitatórios com base em dados atualizados de consumo, evitando descontinuidade no fornecimento por atrasos ou falhas contratuais							
Ação N.º 5	Estabelecer fluxo de comunicação entre a CAF e as UBS, para informar sobre entregas, estoques e eventuais atrasos no fornecimento							
Ação N.º 6	Realizar articulação junto a CIR/CIB para regulamentação das competências do financiamento das fraldas							
4.1.7	**Implantar na APS, alternativas terapêuticas, planta medicinais (farmácia viva) e fitoterápicos da RENAME.**	**Número de alternativas terapêuticas implantadas na APS.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**2**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Elaborar projeto técnico para implantação da Farmácia Viva, contemplando cultivo, beneficiamento e dispensação de plantas medicinais, conforme diretrizes do edital de chamamento público do processo seletivo de projetos para implantação e/ou estruturação de farmácias vivas da SECTICS/MS							
Ação N.º 2	Constituir grupo de trabalho intersetorial (Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Vigilância Sanitária e Agricultura) para coordenar as ações da Farmácia Viva e o uso de fitoterápicos							
Ação N.º 3	Selecionar plantas a serem cultivadas e manipuladas							
Ação N.º 4	Firmar parcerias de cooperação técnica com as Instituições acadêmicas (Universidades e Escolas Técnicas)							
Ação N.º 5	Selecionar duas opções de fitoterápicos da RENAME vigente, com base nas condições de saúde mais prevalentes na APS e nos protocolos do Ministério da Saúde							
Ação N.º 6	Capacitar profissionais da APS e farmacêuticos sobre uso racional de fitoterápicos e plantas medicinais, segurança, indicações terapêuticas e manejo clínico integrado							
Ação N.º 7	Elaborar cartilha de orientações técnicas municipais para prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos, com base no Memento Fitoterápico da ANVISA							
4.1.8	**Garantir a presença do farmacêutico na gestão e cuidado farmacêutico em das farmácias do SUS municipal.**	**Percentual de farmácias públicas com profissional farmacêutico.**	**2024**	**12,90%**	**percentual**	**≥30%**	**60%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar diagnóstico situacional das unidades de saúde e farmácias do SUS municipal, identificando o quantitativo de farmacêuticos, lacunas de cobertura e demandas prioritárias							
Ação N.º 2	Articular elaboração do plano de provimento e lotação de farmacêuticos, considerando critérios técnicos e o cumprimento da Lei nº 13.021/2014, que assegura a presença do profissional responsável técnico em todas as farmácias							
Ação N.º 3	Articular a inserção de farmacêuticos nos processos seletivos ou concursos públicos, conforme a necessidade identificada no diagnóstico							

Ação N.º 4	Capacitar farmacêuticos nas áreas de gestão da AF, incluindo programação, aquisição, controle de estoques, sistemas de informação (Hórus) e indicadores de desempenho							
Ação N.º 5	Implantar rotina de reuniões técnicas entre farmacêuticos e a diretoria/gerencias da AF, para acompanhamento dos processos de aquisição, distribuição, cuidado farmacêutico e monitoramento do acesso e do uso racional de medicamentos							
Ação N.º 6	Incluir os farmacêuticos nas comissões técnicas do município, fortalecendo sua atuação estratégica							
Ação N.º 7	Implantar ações de cuidado farmacêutico nas UBS, priorizando acompanhamento de pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma, dislipidemia)							
Ação N.º 8	Promover ações sobre uso racional de medicamentos com profissionais da APS e comunidade							
4.1.9	**Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica do SUS no município, conforme os eixos do Qualifar-SUS (Estrutura-equipamento e mobiliários, Gestão, Cuidado e Educação).**	**Percentual de farmácias públicas estruturadas e qualificadas de acordo com os eixos do Qualifar-SUS.**	**2024**	**0%**	**percentual**	**≥10%**	**40%**	**percentual**
Ação N.º 1	Implantar legalmente a Diretoria de Assistência Farmacêutica no município (Lei, Decreto Municipal e outros)							
Ação N.º 2	Normatizar o funcionamento da CAF e das farmácias dos serviços SUS com a aquisição dos documentos legais de funcionamento e documentos padrões operacionais. (Alvará Sanitário e Certidão de Regularidade Técnica, POPs)							
Ação N.º 3	Realizar alimentação sistemática do sistema de gerenciamento para manutenção do custeio do QUALIFARSUS (HÓRUS/ESUS AF) com envio dos dados da AF local para Base Nacional (BNAFAR)							
Ação N.º 4	Prover a execução e manutenção do Programa QUALIFARSUS no município.							
Ação N.º 5	Realizar aquisição de equipamentos e mobiliários necessários para estruturação da CAF e das farmácias do SUS							
Ação N.º 6	Realizar articulação para oferecer educação permanente como cursos presenciais, EAD de qualificações para os profissionais da AF, na lógica das Redes de Atenção à Saúde (curso, seminários, pós graduações Lato Sensu e outros.)							
Ação N.º 7	Inserir o profissional farmacêutico nas práticas clinicas dos serviços de saúde com foco na melhoria da resolutividade das ações em saúde, otimizando benefício ao usuário e minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia							
Ação N.º 8	Realizar articulação para a inserção do profissional farmacêutico nas equipes multiprofissional (eMult) da APS							
4.1.10	**Realizar a aquisição/construção/reforma de um prédio próprio para a Central de Abastecimento Farmacêutico do município.**	**Central de Abastecimento Farmacêutico funcionando em imóvel próprio que atenda os parâmetros das RDC's sanitárias.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**

4.1.11	**Implantar soluções digitais na Assistência Farmacêutica municipal alcançando das farmácias públicas.**	**Percentual de soluções digitais (HÓRUS/ E- SUS AF) implantadas nas farmácias públicas.**	**2024**	**0%**	**percentual**	**≥30%**	**60%**	**percentual**
Ação N.º 1	Prover a efetivação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica do SUS – HÓRUS na CAF com seu funcionamento integral e efetivo							
Ação N.º 2	Descentralizar o sistema HÓRUS para as farmácias de serviços SUS melhorando a transmissão das informações para Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica – BNAFAR							
Ação N.º 3	Realizar manutenção dos equipamentos de informática e conectividade necessária para execução do Sistema HÓRUS nos serviços							
Ação N.º 4	Realizar cadastro e treinamento dos profissionais das farmácias para manuseio do HÓRUS							
4.1.12	**Reduzir novas demandas judiciais para fornecimento de medicamentos e insumos farmacêuticos relacionados as novas demandas para AF em 2024.**	**Percentual de novas demandas judiciais relacionadas à Assistência Farmacêutica.**	**2024**	**100% (22) processos novos**	**percentual**	**≥0,5%**	**2%**	**percentual**
Ação N.º 1	Articular a criação do fluxo administrativo de Solução de Conflitos para receber as solicitações da população, analisar tecnicamente em curto prazo (7 a 15 dias) e propor soluções técnica e célere com foco em evitar a judicialização							
Ação N.º 2	Articular a instituição e formalização da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (portaria municipal instituindo o fluxo administrativo e comissão técnica							
Ação N.º 3	Formalizar canal técnico e coordenação interfederativa permanente com a Assistência Farmacêutica Estadual criando em conjunto um grupo formal de comunicação institucional para diagnostico situacional das judicializações, discussão e proposições de cooperação que permita antecipar desabastecimento e possíveis judicializações							
Ação N.º 4	Supervisionar os processos de pacientes cadastrados no Unidade de Dispensação de Medicamentos Especializados - UDME no município para a aquisição dos medicamentos especializados de alto custo de responsabilidade do MS e SES, com produção de planilha mensal de monitoramento de desabastecimento e impacto financeiro municipal							
Ação N.º 5	Emitir relatórios técnicos (assinados pelo responsável farmacêutico e financeiro) documentando medicamentos de competência estadual judicializados e o custo assumido pelo município encaminhando para diretoria jurídica, anexando ainda, nas reuniões da CIR (Comissão Intergestores Regional) para ciência e providencias							
Ação N.º 6	Propor na CIR e CIB a criação de um Fluxo de Responsabilidade Compartilhada, fluxo que defina como o município deve proceder em caso de ausência temporária do Estado (prazos de reposição, substituição temporária, reembolso, comunicação de urgência) evitando disputas e judicializações que recaiam injustamente sobre o município							
Ação N.º 7	Registrar formalmente a ausência estadual (ofício técnico) e comunicar ao Judiciário/MP/procuradoria/defensoria local sempre que houver falta prolongada de medicamento estadual, informando a situação e anexando evidências (notas fiscais, ofícios, respostas do Estado)							
Ação N.º 8	Elaborar fluxograma de integração entre Ouvidoria e Assistência Farmacêutica							
4.1.13	**Implantar o Sistema de Logística Reversa de Medicamentos nas Unidade de Saúde Municipais.**	**Percentual de unidades de saúde com sistema de logística reversa implantado.**	**2024**	**0%**	**percentual**	**≥20%**	**50%**	**percentual**
Ação N.º 1	Implantar pontos de coleta padronizados nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS), na UPA, e em demais serviços municipais de saúde							

Ação N.º 2	Estabelecer fluxo interno de recolhimento e transporte dos medicamentos descartados para a Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF)
Ação N.º 3	Firmar parceria com empresa licenciada para tratamento e destinação final de resíduos farmacêuticos
Ação N.º 4	Capacitar os profissionais das unidades sobre procedimentos corretos de segregação, armazenamento temporário e registro dos resíduos
Ação N.º 5	Desenvolver ações educativas junto aos usuários sobre o descarte seguro de medicamentos domiciliares
Ação N.º 6	Monitorar e registrar os quantitativos coletados, o destino final e os relatórios de conformidade ambiental

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DIRETRIZ 5: Integrar e fortalecer de forma articulada todas as áreas da Vigilância em Saúde, ampliando a capacidade de prevenção, detecção, monitoramento e resposta a agravos, e promovendo ações intersetoriais que garantam proteção integral à saúde da população.

OBJETIVO 5.1: Integrar e fortalecer as ações de Vigilância em Saúde por meio da qualificação dos sistemas de informação, da ampliação da capacidade de detecção, monitoramento e resposta a agravos, do fortalecimento do trabalho intersetorial e da articulação entre ações epidemiológicas, sanitárias, ambientais, de saúde do trabalhador e zoonoses, também com a Atenção Primária e demais níveis de atenção, garantindo ações mais oportunas, eficientes e orientadas às necessidades sanitárias e laborais da população.

Nº	Descrição da Meta	Indicador de Meta	Linha de Base do Indicador			2026	Meta do PMS 2026 a 2029	Unidade de medida
			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida			
5.1.1	**Aumentar a proporção de casos de malária tratados em tempo oportuno.**	**Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno.**	**2024**	**24%**	**Percentual**	**70%**	**70%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Realizar levantamentos entomológicos regulares para identificação de espécies de anofelinos e para mapear áreas de transmissão ativa e priorizar ações							
Ação N.º 2	Ampliar testagem e supervisão de tratamento							
Ação N.º 3	Assegurar acesso gratuito e imediato à medicação, conforme o esquema terapêutico preconizado							
Ação N.º 4	Desenvolver campanhas educativas sobre sinais e sintomas da malária e importância do diagnóstico precoce							
Ação N.º 5	Realizar parcerias com lideranças comunitárias, escolas e associações locais para promoção de vigilância participativa							

Ação N.º 6	Implementar e atualizar anualmente o Plano Municipal de Enfrentamento da Malária							
5.1.2	**Reduzir o percentual de casos de AIDS diagnosticados em estágio avançado.**	**Percentual de casos novos de AIDS diagnosticados com LT-CD4 < 200 cels/mm3.**	**2024**	**34%**	**Percentual**	**30%**	**30%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Realizar ações extramuros de testagens realizadas pelo CTA/SAE							
Ação N.º 2	Realizar ações voltadas para os grupos de maior vulnerabilidade e risco para o HIV/AIDS							
Ação N.º 3	Aumentar a oferta de autoteste para os usuários que utilizam PREP							
Ação N.º 4	Acompanhar os pacientes com HIV/AIDS diagnosticados no Hospital Geral de Parauapebas referenciados aos CTA/SAE							
5.1.3	**Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos em 0 até 2029.**	**Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**0**	**0**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Fornecer testagem rápida para HIV no pré-natal em todas as gestantes em todas as UBS							
Ação N.º 2	Acompanhar gestantes com HIV no SAE							
Ação N.º 3	Acompanhar crianças expostas com HIV no SAE							
Ação N.º 4	Acompanhar parturientes referenciadas pela Maternidade Municipal no SAE							
Ação N.º 5	Capacitar equipes da APS, hospitalar e maternidades sobre prevenção da transmissão vertical e manejo clínico							
5.1.4	**Ampliar a proporção de contatos de TB pulmonar examinados.**	**Proporção de contatos de TB examinados**	**2024**	**39,70%**	**Percentual**	**55%**	**70%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Acompanhar rotineiramente os indicadores de exames de contatos							
Ação N.º 2	Identificar UBS com baixos percentuais e planejar intervenções direcionadas							
Ação N.º 3	Enviar boletins mensais de acompanhamento de pacientes às equipes da APS							
Ação N.º 4	Realizar monitoramento mensal do SINAN para garantir registros completos e corretos							
Ação N.º 5	Realizar visitas técnicas de supervisão nas UBS							
Ação N.º 6	Apoiar a APS na organização de campanhas educativas sobre prevenção e diagnóstico precoce da TB e mutirões para exame de contatos							
Ação N.º 7	Realizar capacitações periódicas aos profissionais sobre fluxos e protocolos do programa de TB							
Ação N.º 8	Articular com a gestão sobre a falta de insumos para a vigilância de contatos							

5.1.5	**Reduzir o percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes.**	**Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes.**	**2024**	**21%**	**Percentual**	**20%**	**≤17%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Prover testagem rápida de sífilis em todas as gestantes no 1º trimestre, com repetição no 3º trimestre							
Ação N.º 2	Monitorar a testagem rápida no momento do parto							
Ação N.º 3	Monitorar as titulações de VDRL durante a gestação							
Ação N.º 4	Realizar ações educativas e campanhas intersetoriais de prevenção e conscientização							
Ação N.º 5	Treinar profissionais da assistência ao pré natal e rede hospitalar sobre classificação e tratamento adequados e em tempo oportuno em parceria com a Rede Alyne.							
Ação N.º 6	Sensibilizar sobre a importância da adesão ao tratamento pelos parceiros							
Ação N.º 7	Monitorar o registro do tratamento realizado pelas gestantes incentivando a referência e contrarreferência entre APS, APGAR e Maternidade							
5.1.6	**Alcançar e manter cobertura vacinal selecionadas (Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) em crianças menores de 1 ano de idade, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).**	**Proporção de vacinas selecionadas com cobertura ≥95%**	**2024**	**70%**	**Percentual**	**95%**	**95%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Incentivar microplanejamento das ações de imunização na APS, priorizando áreas com baixa cobertura e maior vulnerabilidade							
Ação N.º 2	Realizar rotina mensal de monitoramento das coberturas vacinais por UBS							
Ação N.º 3	Adquirir estoque adequado e contínuo de imunobiológicos e insumos (seringas, cartões, caixas térmicas)							
Ação N.º 4	Promover campanhas municipais e Dias D de vacinação com apoio intersetorial							
Ação N.º 5	Fortalecer a integração APS/Vigilância para busca e acompanhamento de faltosos							
Ação N.º 6	Realizar visitas técnicas em todas as salas de vacina do município							
Ação N.º 7	Capacitar sistematicamente vacinadores e técnicos de sala de vacina sobre boas práticas e registro no SIPNI e e-SUS APS (PEC)							
Ação N.º 8	Intensificar ações de comunicação social e combate à desinformação vacinal (redes sociais, escolas, rádios)							
Ação N.º 9	Disponibilizar veículo e apoio operacional durante as ações de campo e campanhas							

5.1.7	**Capacitar as Unidades de Saúde, públicas e privadas, para a notificação de violências interpessoais e autoprovocadas.**	**Percentual de unidades de saúde capacitadas para notificação de violências**	**2024**	**S/I**	**Percentual**	**20%**	**80%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Elaborar e executar Plano de Capacitação para Notificação de Violências, com cronograma anual abrangendo APS, hospitais e serviços privados							
Ação N.º 2	Promover oficinas intersetoriais com participação de CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Educação e Segurança Pública							
Ação N.º 3	Capacitar notificadores (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais) sobre uso da Ficha de Notificação Individual							
Ação N.º 4	Divulgar materiais técnicos e fluxogramas simplificados para identificação e encaminhamento de casos de violência							
Ação N.º 5	Realizar campanhas temáticas com outros setores (SEMMU, SEMAS) com enfoque na prevenção e na notificação obrigatória							
Ação N.º 6	Implantar painel de monitoramento de notificações de violências com indicadores quadrimestrais por tipo de violência e faixa etária							
5.1.8	**Alcançar e manter a realização de exames nos contatos de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.**	**Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.**	**2024**	**80%**	**Percentual**	**82%**	**82%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Acompanhar rotineiramente os indicadores de exames de contatos							
Ação N.º 2	Identificar UBS com baixos percentuais e planejar intervenções direcionadas							
Ação N.º 3	Enviar boletins mensais de acompanhamento de pacientes às equipes da APS							
Ação N.º 4	Realizar monitoramento mensal do SINAN para garantir registros completos e corretos							
Ação N.º 5	Realizar visitas técnicas de supervisão nas UBS							
Ação N.º 6	Apoiar a APS na organização de campanhas educativas sobre prevenção e diagnóstico precoce da hanseníase e mutirões para exame de contatos							
Ação N.º 7	Realizar capacitações periódicas aos profissionais sobre fluxos e protocolos do programa de hanseníase							
5.1.9	**Aumentar o número de atividades educativas realizadas pela vigilância sanitária.**	**Número de atividades educativas realizadas ao ano pela vigilância sanitária.**	**2024**	**29**	**número absoluto**	**40**	**70**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Elaborar Plano Anual de Ações Educativas da Vigilância Sanitária, com metas e cronograma							
Ação N.º 2	Desenvolver campanhas temáticas mensais (boas práticas de manipulação, alimentos, medicamentos, serviços de saúde, água, resíduos, estética, escolas, entre outros)							
Ação N.º 3	Promover palestras, rodas de conversa e oficinas educativas em escolas, feiras livres, indústrias e estabelecimentos de saúde							
Ação N.º 4	Produzir materiais educativos padronizados e acessíveis (folders, banners, vídeos e cartilhas digitais)							
Ação N.º 5	Prover o aumento de pessoal para realização das ações							

Ação N.º 6	Criar indicador de desempenho interno com devolutiva bimestral às equipes							
Ação N.º 7	Realizar mostra municipal de boas práticas em vigilância sanitária educativa ao final do quadriênio							
5.1.10	**Capacitar as Unidades de Saúde, públicas e privadas, para notificação de acidentes/doenças relacionadas ao trabalho.**	**Percentual de estabelecimentos de saúde com CNES ativo capacitados para notificação de acidentes/doenças relacionadas ao trabalho.**	**2024**	**S/I**	**Percentual**	**20%**	**80%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Realizar oficinas de formação para registro das fichas/formulários de notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho							
Ação N.º 2	Produção e distribuição de materiais informativos para os trabalhadores e população em geral							
Ação N.º 3	Realizar monitoramento com devolutiva sistemática nas unidades sobre os registros das notificações							
Ação N.º 4	Estabelecer painel municipal de agravos relacionados ao trabalho com indicadores e evolução histórica							
5.1.11	**Construir uma nova sede para o Centro de Testagem e Acolhimento/Serviços de Atendimento Especializado (CTA/SAE), que atenda os pré-requisitos estruturais do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária.**	**Nova sede do CTA/SAE construído.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
5.1.12	**Reestruturar e ampliar a capacidade física e assistencial do CTA/SAE adequando sua estrutura às normativas do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária, compatibilizando-a com a demanda epidemiológica da região.**	**CTA ampliada e reestruturada.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
5.1.13	**Qualificar os serviços da Vigilância em Saúde por meio do abastecimento regular de insumos, matérias de consumo e serviços de Manutenção necessários para os desenvolvimentos das atividades.**	**Percentual de serviços da Vigilância em Saúde abastecidos regularmente com materiais de consumo, insumos e serviços de manutenções essenciais.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**75%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Firmar contratos contínuos de manutenção para os equipamentos e veículos da Vigilância em Saúde							
Ação N.º 2	Informatizar o almoxarifado específico da Vigilância em Saúde							

5.1.14	**Qualificar as estruturas e os serviços da Vigilância em Saúde por meio da aquisição de equipamentos, mobiliários e bens permanentes.**	**Percentual de serviços Vigilância em Saúde com equipamentos, mobiliários e bens permanentes adequados às suas atividades.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**75%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Priorizar a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, tablets, smartphones) para as equipes de campo e de retaguarda da Vigilância.							
Ação N.º 2	Direcionar parte das aquisições para a renovação das câmaras de conservação de imunobiológicos (Rede de Frio) e para o parque tecnológico do Laboratório de Saúde Pública/CTA.							
5.1.15	**Garantir suporte logístico às equipes de Vigilância em Saúde mediante disponibilização de frota, assegurando mobilidade adequada para a execução das ações de inspeção, monitoramento, investigação e controle.**	**Percentual de demandas de campo da Vigilância em Saúde atendidas com suporte de transporte adequado.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**75%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Elaborar projetos técnicos e submetê-los ao Ministério da Saúde para captação de recursos via emendas ou programas federais, desonerando o Tesouro Municipal							
5.1.16	**Estruturar a Unidade de Vigilância e Zoonoses – UVZ adequando sua estrutura as necessidades e as normativas do MS e da VISA.**	**UVZ estruturada.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
5.1.17	**Realizar investigação dos óbitos maternos.**	**Percentual de óbitos materno investigados.**	**2024**	**100%**	**percentual**	**100%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Determinar que os relatórios das investigações dos óbitos sejam encaminhados obrigatoriamente aos grupos condutores da Rede Alyne, para adequação imediata dos fluxos de urgência obstétrica e do Ambulatório de Gestação de Alto Risco (AGPAR)							
Ação N.º 2	Instituir uma portaria local que determine prazos rigorosos para a equipe de vigilância: toda investigação de morte materna de residente deve ser concluída e digitada no SIM no prazo máximo de 60 dias após o óbito, garantindo o alcance das metas de repasse federal do PQA-VS							
Ação N.º 3	Realizar capacitação contínua dos médicos do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) e hospitais privados para o correto preenchimento da Declaração de Óbito (DO), mitigando o uso de causas mal definidas ("Códigos Garbage") e permitindo a identificação exata das mortes ligadas ao ciclo gravídico-puerperal							
Ação N.º 4	Sempre que o Comitê e a Vigilância concluírem a investigação de um óbito materno evitável, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de origem da paciente deverá ser notificada para que a equipe de Saúde da Família promova uma discussão de caso interno, revisando as falhas cometidas no pré-natal local (ex: falta de exames de sífilis, subestimação de hipertensão)							
5.1.18	**Realizar investigação dos óbitos infantil e fetal.**	**Percentual de óbitos infantil e fetal investigados.**	**2024**	**90%**	**percentual**	**90%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Garantir logística para que a equipe de vigilância realize entrevistas domiciliares e hospitalares (Autópsia Social/Verbal)							

Ação N.º 2	Instituir Fluxo Operacional Padrão (POP) estabelecendo que toda investigação de óbito infantil e fetal seja concluída e digitada no SIM em até 60 dias.							
Ação N.º 3	Estabelecer que, para cada óbito infantil/fetal considerado "evitável" por falha no pré-natal, a Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável seja notificada.							
Ação N.º 4	Treinar anualmente os médicos do Hospital Geral de Parauapebas, do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e das maternidades conveniadas.							
5.1.19	**Implementar e manter ativo os Comitês Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal.**	Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal implantados.	2024	1	número absoluto	1	1	número absoluto
Ação N.º 1	Instituir a obrigatoriedade de prestação de contas dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) ao Comitê.							
Ação N.º 2	Criar o fluxo do "Alerta Assistencial"							
5.1.20	**Manter ou ampliar o resultado do município na Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS).**	**Percentual alcançado pelo município no PQA-VS.**	**2024**	**90%**	**percentual**	**≥90%**	**≥90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Treinar equipes da Atenção Primária e Hospitais para eliminar campos "em branco" nas fichas de notificação do SINAN.							
Ação N.º 2	Evitar o desabastecimento de testes rápidos e vacinas vinculados às metas do PQA-VS							
Ação N.º 3	Estabelecer fluxos de investigação rápida de óbitos suspeitos de Dengue e Chikungunya.							
GESTÃO EM SAÚDE DO SUS								
DIRETRIZ 6: Qualificar a gestão do Sistema Municipal de Saúde com foco na governança, regionalização, articulação interfederativa, fortalecimento do planejamento, da regulação, controle e avaliação, da gestão financeira, da participação social, da transparência e da qualidade dos serviços e da incorporação e inovação da saúde digital, garantindo eficiência administrativa e melhoria contínua da atenção à saúde								
OBJETIVO 6.1: Fortalecer a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando organização, eficiência, transparência e suporte adequado às ações e serviços de saúde do município.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS**	**Unidade de medida**

			Ano	Valor da linha de base	Unidade de medida		2026 a 2029	
6.1.1	**Alcançar a regularização dos estabelecimentos de saúde municipais por meio da obtenção e manutenção da Licença Sanitária, Licença Ambiental, Licença de Funcionamento e Licença do Corpo de Bombeiros, bem como a implementação da gestão integrada dos resíduos de serviços de saúde (RSS), assegurando o manejo, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente.**	**Percentual de unidades de saúde com manejo e destinação adequada de RSS conforme legislação vigente.**	**2024**	**100%**	**percentual**	**100%**	**100%**	**percentual**
Ação N.º 1	Atender as condicionantes para obtenção e renovação das licenças (sanitária, ambiental, de funcionamento e do Corpo de Bombeiros), por meio de intervenções estruturais, correções sanitárias, atualização de projetos técnicos e organização documental.							
Ação N.º 2	Melhorar ou estruturar a operacionalização do manejo, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos em todas as unidades de saúde.							
Ação N.º 3	Implantar a coleta seletiva com a segregação de resíduos comuns recicláveis, com disponibilização de recipientes adequados, definição de fluxos internos e articulação com sistemas de coleta e destinação.							
Ação N.º 4	Implementar rotinas de acompanhamento, controle de prazos das licenças, auditorias internas e capacitação das equipes para garantir a manutenção da regularização e conformidade com a legislação vigente.							
6.1.2	**Realizar articulação intersetorial para a construção de sede própria da Secretária Municipal de Saúde.**	**Sede da SEMSA construída.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
6.1.3	**Garantir o funcionamento contínuo e qualificado dos serviços da Secretaria Municipal de saúde no município com o provimento de materiais de consumo e serviços de manutenção.**	**Serviços da SEMSA abastecidos regularmente com materiais de consumo e serviços de manutenções essenciais.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**≥75%**	**≥90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Estabelecer um cronograma anual consolidado para licitações e aquisições de materiais de consumo, utilizando o histórico de consumo das unidades para evitar rupturas de estoque							

Ação N.º 2	Instituir rotinas rigorosas de fiscalização e execução de contratos de manutenção preventiva e corretiva (predial, frota e equipamentos médico-hospitalares) em toda a rede							
Ação N.º 3	Implementar um sistema informatizado de gestão logística integrada que monitore em tempo real os níveis de estoque em cada unidade de saúde, estabelecendo alertas automáticos de estoque mínimo e prazos de validade para assegurar a reposição programada sem interrupções na assistência.							
6.1.4	**Qualificar as estruturas da Secretaria Municipal de Saúde por meio da aquisição de bens permanentes (equipamentos, mobiliários e etc.)**	**Percentual de serviços da SEMSA com equipamentos, mobiliários (bens permanentes) adequados às suas atividades.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**75%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Realizar um levantamento contínuo das necessidades de mobiliários, equipamentos de informática e aparelhos médico-hospitalares em cada unidade ou setor administrativo.							
Ação N.º 2	Executar os trâmites de compra e distribuição desses bens permanentes, garantindo que as equipes tenham a estrutura necessária para realizar suas atividades							
Ação N.º 3	Acompanhar o avanço do "Percentual de serviços da SEMSA com equipamentos adequados"							
6.1.5	**Identificar e inventariar, anualmente, os bens permanentes inservíveis da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), com vistas à adoção das providências administrativas para desfazimento e/ou leilão público.**	**Percentual de bens permanentes inservíveis identificados e inventariados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**100%**	**100%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Instituir um cronograma obrigatório para que todas as unidades de saúde relatem equipamentos, macas, computadores e mobiliários quebrados ou obsoletos.							
Ação N.º 2	Estruturar o processo administrativo para realizar o leilão público dos itens que ainda possuem valor de sucata ou providenciar o descarte ecológico adequado, visando cumprir o indicador de 100% dos bens inservíveis inventariados a cada ano							
6.1.6	**Realizar manutenção preventiva, corretiva e/ou reforma predial nas unidades próprias vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), conforme diagnóstico técnico das áreas.**	**Percentual de unidades de saúde com manutenção e/ou reforma executada no período.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**40%**	**100%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Realizar levantamentos e vistorias periódicas para identificar com exatidão as necessidades estruturais (hidráulicas, elétricas e civis) de cada unidade de saúde							
Ação N.º 2	Estruturar e executar um plano contínuo de manutenção preventiva e corretiva, evitando interrupções nos atendimentos por falhas na infraestrutura							
Ação N.º 3	Realizar as obras necessárias para que os prédios cumpram as normas sanitárias e de acessibilidade vigentes, garantindo um ambiente seguro e acolhedor							

6.1.7	**Assegurar, anualmente, a locação de imóveis que atendam às exigências técnicas, sanitárias e de segurança, destinados ao funcionamento das unidades da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA) que não dispõem de sede própria.**	**Percentual de unidades sem sede própria com contrato de locação vigente e regular.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**100%**	**100%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Avaliar rigorosamente as unidades de saúde que atualmente funcionam em prédios alugados no município , verificando se continuam atendendo às exigências sanitárias, técnicas e de segurança							
Ação N.º 2	Exigir laudos técnicos (de engenharia, acessibilidade e vigilância sanitária) antes de assinar ou renovar qualquer contrato de locação, assegurando que a infraestrutura do imóvel suporta os serviços de saúde que serão prestados.							
Ação N.º 3	Instituir um fluxo administrativo para planejar e renovar anualmente os contratos com antecedência, evitando o vencimento, multas ou a interrupção dos atendimentos à população							
6.1.8	**Assegurar a disponibilidade de frota de veículos dimensionada como necessária para atender às demandas operacionais da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA).**	**Percentual de veículos disponíveis em relação à frota necessária planejada.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**≥90%**	**≥90%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Mapear a demanda real de transporte (para pacientes, equipes de saúde e setor administrativo) e realizar a aquisição ou locação de veículos para suprir as deficiências da frota atual							
Ação N.º 2	Executar cronogramas contínuos de manutenção preventiva e corretiva para todos os veículos, minimizando o tempo de frota parada e garantindo a segurança de motoristas e passageiros							
Ação N.º 3	Implementar um controle centralizado de rotas, consumo de combustível e agendamento de viagens, otimizando o uso diário dos veículos em todos os pontos da rede							
6.1.9	**Mapear, padronizar e regulamentar os processos administrativos e operacionais prioritários da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo maior eficiência, transparência e segurança institucional.**	**Percentual de processos administrativos padronizados e regulamentados.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**≥60%**	**≥90%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Realizar um levantamento de todos os fluxos de trabalho nos setores prioritários da secretaria (como planejamento, regulação, assistência farmacêutica e recursos humanos), identificando gargalos, retrabalhos e etapas desnecessárias							
Ação N.º 2	Desenvolver e documentar Manuais Técnico-Normativos e POPs para cada rotina administrativa e assistencial. A padronização garante que as tarefas sejam executadas com a mesma qualidade e eficiência, independentemente de mudanças na equipe, minimizando erros e desperdícios							

Ação N.º 3	Validar e publicar oficialmente esses novos fluxos e manuais por meio de atos normativos (portarias ou resoluções internas). Isso assegura o respaldo legal para a atuação dos servidores e garante a transparência exigida na gestão pública.							
6.1.10	**Estruturar e qualificar o suporte administrativo às unidades e setores da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo atendimento tempestivo, padronizado e monitorado das demandas internas.**	**Percentual de demandas administrativas atendidas dentro do prazo estabelecido.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**≥75%**	**≥90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Implantar um sistema informatizado (Help Desk) para registrar, categorizar e rastrear todas as solicitações administrativas (como suporte de TI, RH e suprimentos) feitas pelas unidades de saúde ao nível central.							
Ação N.º 2	Estabelecer tempos máximos de resposta e resolução para cada tipo de demanda, garantindo que as unidades da ponta não fiquem desassistidas.							
Ação N.º 3	Treinar os servidores administrativos para executarem suas funções com base nas rotinas que foram padronizadas, reduzindo erros, burocracia e retrabalho.							
OBJETIVO 6.2: Fortalecer o planejamento, monitoramento e avaliação da gestão municipal de saúde, garantindo organização das ações, uso eficiente dos recursos e alinhamento às diretrizes do SUS.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			
6.2.1	**Elaborar, registrar no DigiSUS e encaminhar para o CMS o Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026–2029 para análise e deliberação em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.**	**Plano Municipal de Saúde elaborado, registrado no DigiSUS e encaminhado ao CMS para análise e deliberação.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Garantir a coleta, validação e consolidação de 100% dos dados necessários à elaboração da PMS junto às áreas técnicas da Secretaria de Saúde.							
Ação N.º 2	Elaborar e registrar integralmente o Plano Municipal de Saúde (PMS) no DigiSUS Gestor dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.							
Ação N.º 3	Submeter o PMS à análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde, garantindo apreciação e resolução.							

Ação N.º 4	Realizar a revisão periódica das metas do Plano Municipal de Saúde (PMS), promovendo ajustes, inclusões ou exclusões quando necessário, com base nos resultados dos indicadores, relatórios quadrimestrais e mudanças no cenário epidemiológico, submetendo as alterações à análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde.							
6.2.2	**Elaborar, registrar no DigiSUS a Programação Anual de Saúde (PAS) e encaminhar para análise e aprovação do CMS em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.**	**Programação Anual de Saúde elaborada, registrada no DigiSUS encaminhada ao CMS para análise e aprovação.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**1**	**4**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Garantir a coleta, validação e consolidação de 100% dos dados necessários à elaboração da PAS junto às áreas técnicas da Secretaria de Saúde.							
Ação N.º 2	Elaborar e registrar integralmente a Programação Anual de Saúde (PAS) no DigiSUS Gestor dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.							
Ação N.º 3	Submeter a PAS à análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde, garantindo apreciação e resolução.							
6.2.3	**Elaborar e registrar no sistema DigiSUS, os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), encaminhando-os para análise e considerações do CMS atendendo as normativas do Ministério da Saúde.**	**RDQA elaborados e registrados no DigiSUS e encaminhado para análise e considerações do CMS.**	**2024**	**3**	**número absoluto**	**3**	**12**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Garantir a coleta, validação e consolidação de 100% dos dados quadrimestrais necessários à elaboração do RDQA junto às áreas técnicas da Secretaria de Saúde.							
Ação N.º 2	Elaborar e registrar integralmente o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) no DigiSUS Gestor dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.							
Ação N.º 3	Submeter o RDQA à análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde, garantindo apreciação e resolução.							
6.2.4	**Elaborar e registrar no sistema DigiSUS, o Relatório Anual de Gestão (RAG) encaminhando-o para análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), atendendo as normativas do Ministério da Saúde.**	**RAG elaborados e registrados no DigiSUS para análise e aprovação do CMS.**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**1**	**4**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Garantir a coleta, validação e consolidação de 100% dos dados necessários à elaboração do RAG junto às áreas técnicas da Secretaria de Saúde							
Ação N.º 2	Elaborar e registrar integralmente o Relatório Anual de Gestão (RAG) no DigiSUS Gestor dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.							
Ação N.º 3	Submeter o RAG à análise e deliberação do Conselho Municipal de Saúde, garantindo apreciação e resolução.							
6.2.5	**Monitorar e avaliar, as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde (PMS), utilizando instrumentos de acompanhamento sistemático e análise de desempenho.**	**Percentual de metas do PMS monitoradas e avaliadas no período.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**100%**	**100%**	**percentual**

Ação N.º 1	Criar normativa interna definindo o cronograma rigoroso de repasse de dados pelas diretorias técnicas para a Diretoria de Planejamento. Para inserção dos instrumentos no sistema DigiSUS (maio, setembro e fevereiro), garantindo o rito da Lei Complementar nº 141/2012.							
Ação N.º 2	Monitorar mensalmente e quadrimestralmente as informações e identificar metas que estão abaixo do esperado da proporção esperada para o período, a área técnica responsável deverá apresentar um Plano de Ação corretivo (utilizando ferramentas como PDCA ou 5W2H) na reunião de avaliação da Secretaria.							
6.2.6	**Implantar, Sala de Situação em Saúde no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, destinada ao monitoramento de indicadores, avaliação das metas do PMS e apoio à tomada de decisão estratégica da gestão municipal.**	**Sala de Situação implantada e em funcionamento.**	**2024**	**0**	**Número absoluto**	**1**	**1**	**Número absoluto**
Ação N.º 1	Estabelecer reunião mensal na Sala de Situação para revisar indicadores críticos							
Ação N.º 2	Programar os painéis da Sala de Situação para emitir status visuais e alertas diante de inconsistências epidemiológicas.							
6.2.7	**Implantar e disponibilizar "Painel de Inteligência Estratégica" que gerencia e monitora os indicadores, serviços e produção assistencial da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA) integrando dados do e-SUS APS e e-SUS Ampliado transformando informação em inteligência estratégica para subsidiar o planejamento, a avaliação rigorosa e a tomada de decisão da gestão municipal.**	**Painel gerencial da SEMSA implantado e em funcionamento.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Definir níveis hierárquicos de acesso ao Painel (perfil do secretário, diretor, técnico, gerente de UBS).							
Ação N.º 2	Capacitar o corpo gerencial para a leitura analítica de painéis (Business Intelligence)							
Ação N.º 3	Desenvolver uma interface pública do Painel ("Painel da Transparência em Saúde").							
6.2.8	**Implantar o Núcleo de Avaliação em Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), com a estruturação e operacionalização de um Banco de**	**Banco de dados institucional estruturado e em funcionamento**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**

	Dados institucional em tecnologias, incorporação tecnológica e avaliação econômica em saúde.							
Ação N.º 1	Remanejar/contratar pessoal para compor equipe de gestão de custo							
Ação N.º 2	Designar responsável técnico pela gestão e qualificação das informações de custos em cada estabelecimento de saúde							
Ação N.º 3	Treinar a equipe técnica em metodologias padronizadas para elaboração de estudos de avaliação econômica, gestão de custos e análise de evidências científicas para subsidiar a tomada de decisão							
Ação N.º 4	Implantar Banco de Dados institucional em tecnologias em saúde e avaliações econômicas							
Ação N.º 5	Implementar sistema informatizado para gestão, análise e visualização de dados em saúde							
6.2.9	**Monitorar periodicamente a regularidade da alimentação, validação e envio das informações nos Sistemas de Informação em Saúde, mediante análise técnica dos relatórios de produção e cadastros, subsidiando a gestão na adoção de medidas corretivas quando necessário.**	**Percentual de sistemas monitorados quanto à regularidade de envio no período.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**100%**	**100%**	**Percentual**
Ação N.º 1	Acompanhar mensalmente a transmisssão das remessas de dados ao Ministério da Saúde							
Ação N.º 2	Acompanhar produção ambulatorial para analise técnica dos relatorio de produção							
Ação N.º 3	Monitorar a completude da operacionalização das informações inseridas nos sistemas de informação vigente							
Ação N.º 4	Capacitar continuamente as equipes assistenciais e administrativas sobre o preenchimento no sistema de informação e formulários oficiais							
6.2.10	**Implantar Grupo Condutor da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), visando ao fortalecimento da governança da RAS, à organização dos fluxos assistenciais e ao apoio técnico às áreas executoras da rede.**	**Grupo Condutor da RAS implantado e em funcionamento.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**1**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Instituir Grupo Condutor da Rede de Atenção à Saúde							

Ação N.º 2	Monitoramento da efetividade das linhas de cuidado prioritárias da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, visando à organização da Rede de Atenção à Saúde e à integralidade do cuidado.							
6.2.11	**Implantar e operacionalizar o prontuário eletrônico (priorizando e-SUS) nos serviços da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), garantindo a qualificação dos registros assistenciais, a integração das informações entre os pontos de atenção e a segurança dos dados em saúde.**	**Percentual de unidades de saúde com prontuário eletrônico implantado e em funcionamento.**	**2024**	**S/I**	**percentual**	**≥90%**	**≥90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Capacitar profissionais de saúde para o registro no sistema e-SUS APS							
Ação N.º 2	Adequar protocolos de segurança da informação e proteção de dados do paciente no sistema							
Ação N.º 3	Assegurar a interoperabilidade dos registros eletrônicos em saúde entre os níveis de atenção e a integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)							
OBJETIVO 6.3: Fortalecer a gestão financeira do Fundo Municipal de Saúde, assegurando planejamento, execução orçamentária eficiente, transparência na aplicação dos recursos e conformidade com as normas do SUS.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			
6.3.1	**Implantar/Implementar a gestão de centros de custos na rede de saúde do SUS conforme modulo disponível no ApuraSUS.**	**Percentual de implantação dos centros de custos e Eficácia do gasto público com saúde através da Gestão de Custos**	**2024**	**5%**	**percentual**	**29%**	**80%**	**percentual**
Ação N.º 1	Definir os técnicos responsáveis pelo levantamento de dados nas unidades de saúde							
Ação N.º 2	Enviar mensalmente as planilhas de custos com dados levantados							
Ação N.º 3	Implantar o Sistema ApuraSUS por unidade							
Ação N.º 4	Alimentar os dados no ApuraSUS (Coordenação de Custos)							
Ação N.º 5	Gerar os relatórios e retroalimentação (Coordenação de Custos)							

Ação N.º 6	Capacitar o Pessoal							
OBJETIVO 6.4: Fortalecer a Ouvidoria Municipal do SUS como instrumento de participação social, transparência e melhoria contínua dos serviços de saúde, garantindo escuta qualificada e resposta oportuna às manifestações dos usuários.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			
6.4.1	**Aumentar o percentual de manifestações respondidas ao cidadão em até 30 dias do recebimento na Ouvidoria SUS.**	**Percentual de manifestações respondidas ao cidadão em até 30 dias do recebimento.**	**2024**	**60%**	**percentual**	**70%**	**90%**	**percentual**
Ação N.º 1	Definir etapas, prazos intermediários e responsabilidades claras para análise, encaminhamento, resposta e fechamento das manifestações.							
Ação N.º 2	Estabelecer fluxos formais com os setores da Secretaria de Saúde, com definição de prazos internos inferiores a 30 dias e responsabilização pelo retorno das demandas.							
6.4.2	**Reduzir o Tempo Médio de Resposta Conclusiva da Ouvidoria SUS.**	**Tempo Médio (em dias corridos) entre a abertura da manifestação e a comunicação da resposta conclusiva ao cidadão.**	**2024**	**30**	**número absoluto**	**20**	**13**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Otimizar o fluxo de tramitação das manifestações, priorizando a digitalização completa do processo, desde a abertura até a resposta ao cidadão, eliminando etapas burocráticas							
Ação N.º 2	Conceder autonomia à equipe da Ouvidoria para responder diretamente às manifestações de baixa complexidade (como pedidos de informação) sem necessidade de tramitação externa							
OBJETIVO 6.5: Assegurar o funcionamento regular e qualificado do Conselho Municipal de Saúde, promovendo participação social, transparência e acompanhamento das ações da gestão municipal.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			

6.5.1	**Realizar capacitações continuada para os conselheiros de saúde e comunidade**	**Nº de ações realizadas**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**≥ 4**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Realizar capacitações continuadas com temas diversos							
Ação N.º 2	Articular parcerias com Escolas Técnicas do SUS (ETSUS) e organizações sociais							
Ação N.º 3	Elaborar material didático de apoio.							
6.5.2	**Realizar as Conferências Municipais de Saúde.**	**Nº de conferencias realizadas**	**2024**	**2**	**número absoluto**	**1**	**2**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Planejar e executar as Ações e Atividades inerentes a conferência de Saúde							
Ação N.º 2	Mobilizar a sociedade para a realização das pré-conferências e conferência de saúde.							
Ação N.º 3	Articular parcerias com o Conselho Estadual/Nacional de Saúde							
6.5.3	**Criar e manter canais de comunicação digital do CMS para divulgação das reuniões, pautas e deliberações.**	**Número de canais de informações criados**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**1**	**3**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Contratar/desenvolver o portal do CMS							
Ação N.º 2	Criar o canal oficial no YouTube							
Ação N.º 3	Transmitir ao vivo as reuniões ordinárias do Conselho							
Ação N.º 4	Publicar mensalmente as pautas, atas e resoluções no portal							
Ação N.º 5	Parceria com ouvidoria sus							
Ação N.º 6	Parceria ouvidoria municipal							
Ação N.º 7	Visita técnica nos estabelecimentos de saúde							
Ação N.º 8	Realizar palestras com a comunidade							
Ação N.º 9	Realiza seminário temático							
GESTÃO DO TRABALHO								
DIRETRIZ 7: Fortalecer a gestão do trabalho e o desenvolvimento dos profissionais de saúde, promovendo condições adequadas de trabalho, valorização, qualificação contínua e cuidado integral à saúde do trabalhador do SUS.								

OBJETIVO 7.1: Implementar ações de aprimoramento dos processos de trabalho no SUS, promovendo formação e educação continuada, humanização, qualificação e valorização dos trabalhadores com ênfase no cuidado e acompanhamento à saúde do trabalhador.								
Nº	**Descrição da Meta**	**Indicador de Meta**	**Linha de Base do Indicador**			**2026**	**Meta do PMS 2026 a 2029**	**Unidade de medida**
			Ano	**Valor da linha de base**	**Unidade de medida**			
7.1.1	**Fortalecer e ampliar as ações integradas de promoção, prevenção, assistência e reabilitação à saúde e qualidade de vida dos trabalhadores da SEMSA.**	**Percentual de trabalhadores da SEMSA alcançados com ações de prevenção e promoção a saúde e qualidade de vida no trabalho.**	**2024**	**61%**	**percentual**	**64,50%**	**75%**	**percentual**
Ação N.º 1	Desenvolver ações de saúde ocupacional, prevenção e promoção à saúde do trabalhador							
Ação N.º 2	Fortalecer os grupos terapêuticos, oficinas de autocuidado, rodas de conversa e atendimento em rede							
Ação N.º 3	Promover campanhas e ações integradas de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho (alimentação, atividade física, ergonomia, prevenção ao adoecimento psíquico)							
Ação N.º 4	Realizar ações descentralizadas nos locais de trabalho, com equipes itinerantes							
Ação N.º 5	Incentivar hábitos saudáveis como a prática de atividade física e dieta equilibrada, e oferecer melhores condições para o desempenho das atividades laborais							
Ação N.º 6	Ampliar o cuidado integral aos trabalhadores SEMSA, garantindo o acesso aos serviços de saúde para diagnóstico, tratamento e reabilitação física e mental							
Ação N.º 7	Reduzir recorrência e absenteísmo por adoecimento do trabalhador da SEMSA							
Ação N.º 8	Sistematizar o acompanhamento em processos de adoecimento (físico e mental)							
Ação N.º 9	Implementar o acompanhamento dos trabalhadores em afastamento, readaptação e retorno ao trabalho							
Ação N.º 10	Ambientar o servidor, juntamente com a coordenação de Humanização, nos casos de readaptação e retorno ao trabalho							
7.1.2	**Implantar Plano de Educação Permanente com agenda integrada de capacitações.**	**Plano de Educação Permanente com agenda integrada de capacitações implantado.**	2024	0	percentual	20%	50%	percentual

Ação N.º 1	Elaborar Plano de Educação Permanente/SEMSA							
Ação N.º 2	Implantar Centro de Capacitação de Educação Permanente da SEMSA.							
Ação N.º 3	Elaborar agenda integrada de educação permanente, no âmbito da SEMSA							
Ação N.º 4	Monitorar a aplicabilidade da agenda integrada, no âmbito da SEMSA							
Ação N.º 5	Realizar curso introdutório de novos servidores da SEMSA, em até 30 dias após sua admissão ou mudança de setor de trabalho							
Ação N.º 6	Realizar curso de qualificação em gestão de serviços de saúde para, no mínimo 80% dos gerentes das UBS, até 2029							
7.1.3	**Instituir o Plano Municipal de Integração Ensino-Serviço no âmbito da SEMSA.**	**Plano Municipal de Integração Ensino-Serviço da SEMSA, instituído.**	2024	0	número absoluto	1	1	número absoluto
Ação N.º 1	Elaborar e instituir o Plano Municipal de Integração Ensino-Serviço até dezembro de 2028							
Ação N.º 2	Implementar ações ao Plano Municipal de Integração Ensino-Serviço de acordo com as Diretrizes de integração ensino-serviço do SUS							
Ação N.º 3	Formalizar a articulação entre universidades, escolas técnicas e a SEMSA para o desenvolvimento de atividades de ensino, estágios, residência e capacitação continuada, promovendo integração efetiva entre educação e serviço de saúde							
Ação N.º 4	Georreferenciar as unidades de estágios, residências e afins, identificando as IES vinculadas, até 2028							
Ação N.º 5	Promover ambientação para os preceptores dos campos de prática de estágios e residências multiprofissionais							
Ação N.º 6	Implantar, até 2028, 01 sala (administrativa e técnica) da COREME e COREMU							
Ação N.º 7	Fortalecer a gestão ensino-serviço por meio da articulação entre SEMSA e instituições de ensino							
7.1.4	**Implantar Centro de Capacitação de Educação Permanente da SEMSA.**	**Centro de Capacitação de Educação Permanente da SEMSA implantado.**	**2024**	**0**	**número absoluto**	**Não programado**	**1**	**número absoluto**
7.1.5	**Fortalecer a política de Humanização no SUS de Parauapebas**	**Resultado do Diagnóstico situacional das práticas de humanização no SUS e taxas de implantação dos GTHs**	**2024**	**1**	**número absoluto**	**1**	**4**	**número absoluto**
Ação N.º 1	Implementar Grupos de Trabalho de Humanização (GTHs) em, no mínimo, 60% dos serviços de saúde elegiveis da SEMSA							
Ação N.º 2	Elaborar diagnóstico situacional das práticas de humanização no SUS nos estabelecimentos de saúde da SEMSA, identificando pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria, visando à qualificação do atendimento e fortalecimento da gestão centrada no usuário							
Ação N.º 3	Realizar anualmente 1 Ação de boas práticas no SUS Parauapebas							
Ação N.º 4	Realizar anualmente 1 Forúm Municipal de Humanização							